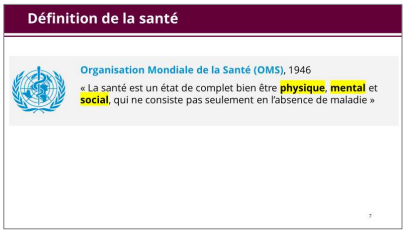
Faculté de médecine - Lundi 26 octobre 2026

UE C.1 – Santé publique, promotion de la santé et prévention, éducation thérapeutique

Sara Kerbouai – Interne en santé publique (sara.kerbouai@universite-paris.saclay.fr)

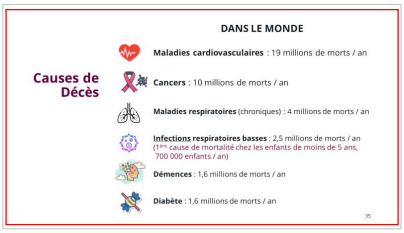
Sophie Novelli – Service de santé publique et d'épidémiologie de l'hôpital Bicêtre (sophie.novelli@universite-paris-saclay.fr)



Diapos avec le titre

en blanc sur violet/bordeaux :

à connaitre



Diapos encadrées en rouge :

fiche synthétique

à connaitre



Autres diapos :

à comprendre

2

Objectifs

Organisation et acteurs du système de santé, enjeux de santé publique
• **Fondements théoriques : définitions, courants, fonction et approche**
• **Acteurs et organismes nationaux et internationaux**
• Mesure et surveillance de l'état de santé des populations, indicateurs et déterminants de santé
• Panorama de la santé en France et dans le monde, inégalités de santé, besoins, accès, recours aux soins, santé globale, littératie en santé
• **Organisation, fonctionnement et enjeux du système de santé en France**
• Approche intersectorielle de la santé publique
• Stratégies et politiques publiques prévalentes : programme national nutrition santé, feuille de route santé mentale et psychiatrie, programme national de lutte contre le tabac, politique des 1000 premiers jours de l'enfant, stratégie nationale de santé sexuelle
• Economie de la santé : financement du système de santé, dépenses de santé, modes de rémunération de professionnels
• **Parcours de soins/parcours de santé, modes d'exercice coordonné**
• Alertes sanitaires, gestion des crises sanitaires et réponses en contexte de pandémie

université PARIS-SACLAY

La Santé Publique

La santé publique - Définition



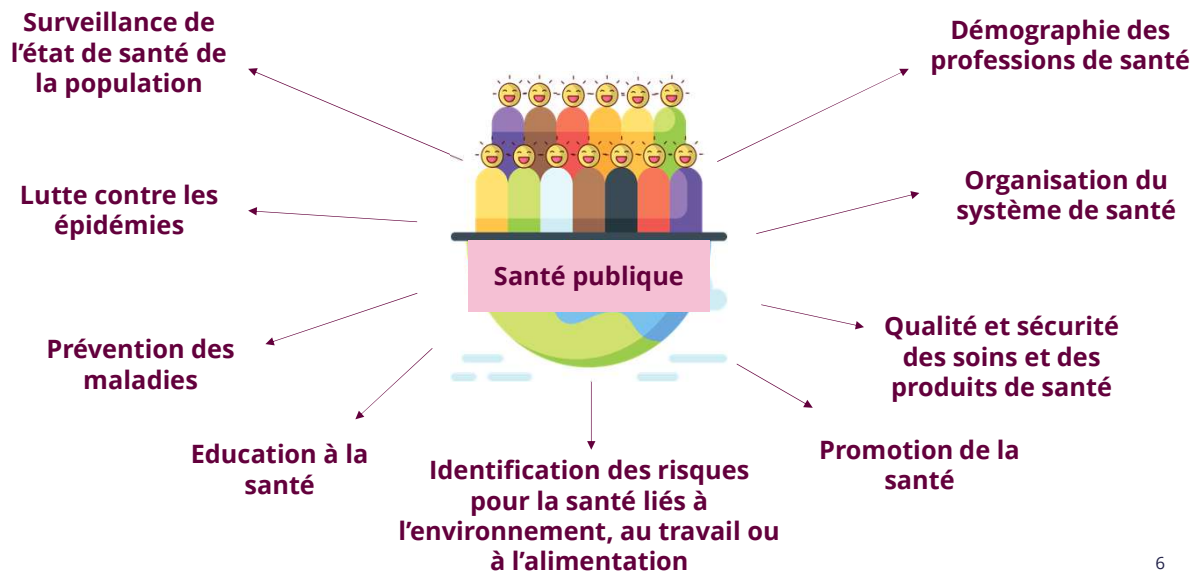
5

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (1952)

« La santé publique est l'art et la science de **prévenir la maladie**, de **prolonger la vie**, d'améliorer la **santé physique et mentale des individus** par une **action collective et concertée** qui vise à assainir le milieu, lutter contre les épidémies, enseigner les règles d'hygiène personnelle, organiser des services médicaux et infirmiers en vue d'un diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies, mettre en œuvre des mesures sociales propres à assurer à chaque membre de la collectivité un niveau de vie compatible avec le maintien de sa santé. »

La santé publique s'intéresse à préserver et améliorer la santé de l'ensemble de la population.

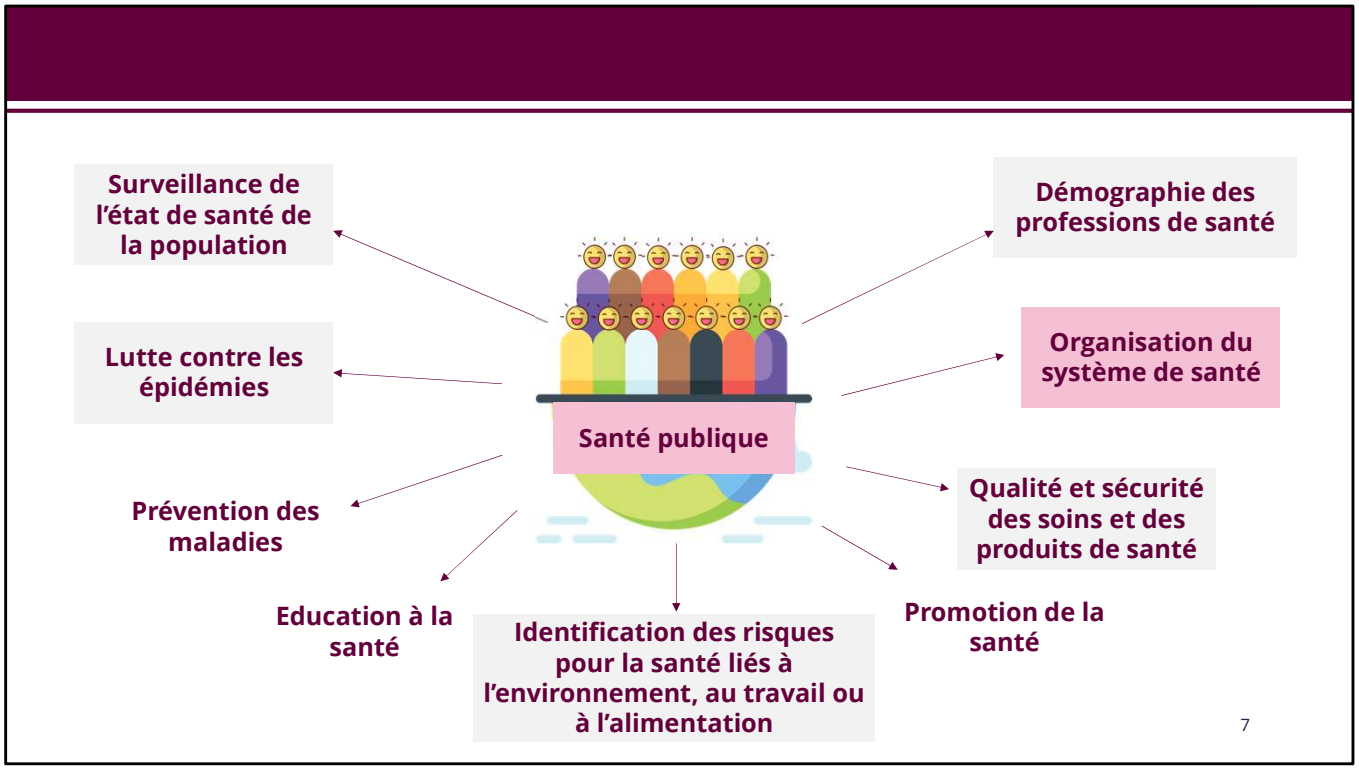
Les domaines de la santé publique



6

En France, c'est la loi du 9 août 2004 « relative à la politique de santé publique » qui a défini les dix domaines qui relèvent de la politique de santé publique :

1. La surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et de ses déterminants
2. La lutte contre les épidémies
3. La prévention des maladies, traumatismes et incapacités
4. L'amélioration de l'état de santé de la population et de la qualité de vie des personnes malades, handicapées, et dépendantes
5. L'information et l'éducation à la santé de la population et l'organisation de débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires à travers les Conférences régionales de santé
6. L'identification et la réduction des risques éventuels pour la santé liée à des facteurs d'environnement, aux conditions de travail ou de transport, à l'alimentation ou à la consommation de produits et de services susceptibles de l'altérer
7. La réduction des inégalités de santé par la promotion de la santé à travers le développement de l'accès aux soins et aux diagnostics sur l'ensemble du territoire
8. La qualité et la sécurité des soins et des produits de santé
9. L'organisation du système de santé et sa capacité à répondre aux besoins de prévention et de prise en charge des maladies et handicaps
10. La démographie des professions de santé

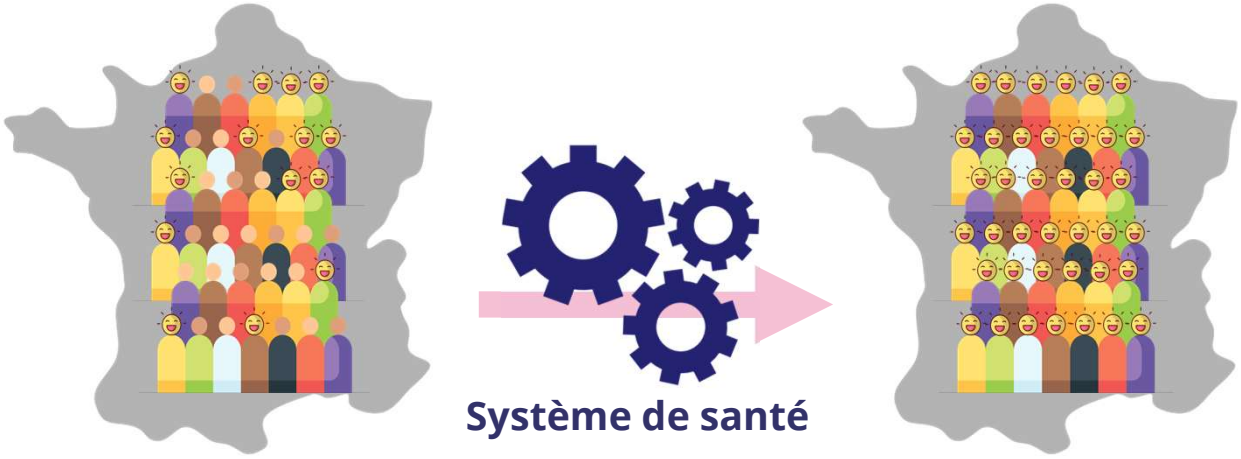


On va s'intéresser dans ce cours à **l'organisation du système de santé**.

université PARIS-SACLAY

Organisation du système de santé

Définition du système de santé

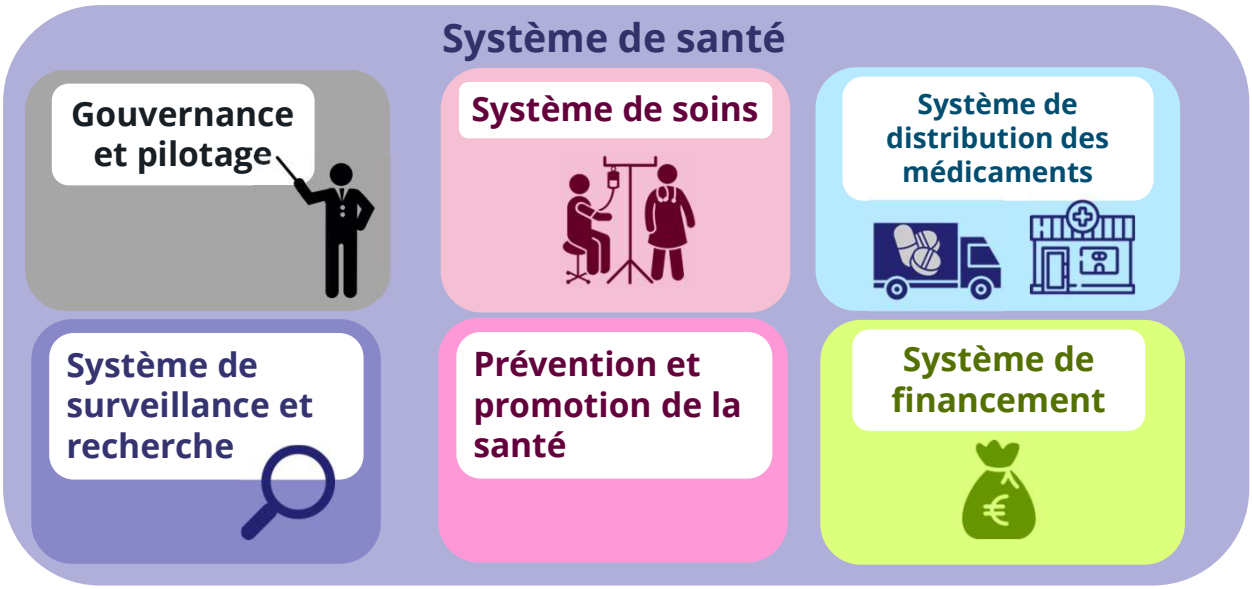


9

C'est quoi un « Système » ? : c'est un ensemble de procédés, de pratiques organisées, destinés à assurer une fonction définie.

Organisation mondiale de la santé
Le système de santé correspond à la totalité des **organisations, institutions et ressources** consacrées à la production d'actions visant principalement à **améliorer**, **maintenir** ou **restaurer** la santé.

Définition du système de santé



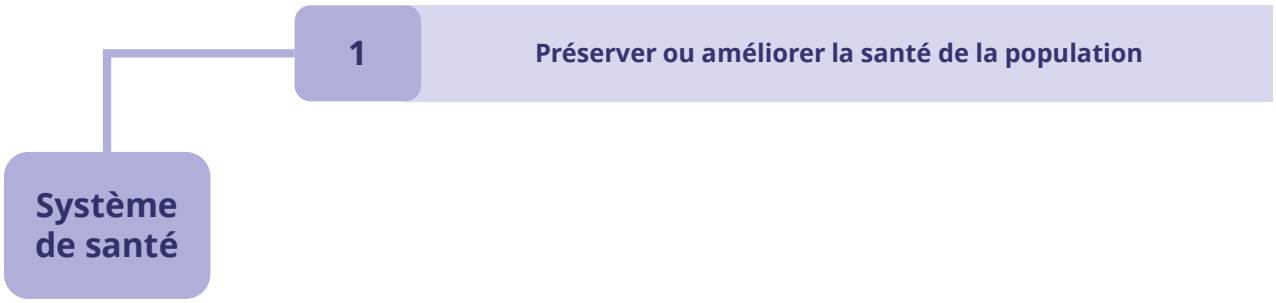
10

Le système de santé comprend donc **toutes les activités** dont le but essentiel est de **promouvoir ou entretenir la santé (dans tous ses aspects).**

Il englobe donc les **soins individuels** (diagnostic, traitement, réadaptation, …), mais va bien au-delà : il inclut également :

- Le système de gouvernance/pilotage/administration
- Les services collectifs de prévention, de promotion, d'éducation pour la santé
- Le système de fabrication et distribution des médicaments et produits de santé
- Le système de financement
- Le système de surveillance sanitaire et de l'innovation médicale

Objectifs du système de santé



11

Le système de santé a plusieurs objectifs :

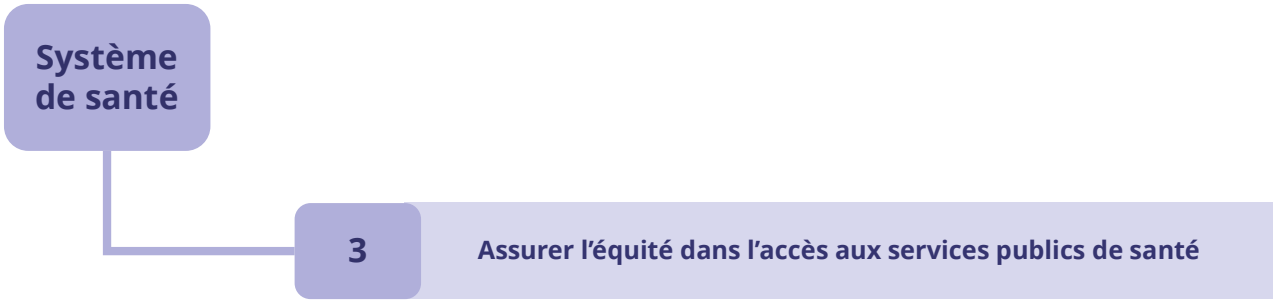
- **Améliorer l'état de santé de la population** : en réduisant la mortalité prématurée, en prévenant les maladies et les conséquences des maladies chroniques, en améliorant l'espérance de vie en bonne santé

Objectifs du système de santé



- **Fournir des services qui répondent aux attentes de la population**, c'est-à-dire :
  - avoir accès aux soins
  - à des soins surs et de bonne qualité
  - et avoir une continuité des soins, c'est-à-dire avoir une prise en charge cohérente lorsque le patient passe d'un professionnel à un autre, de l'hôpital à la ville, etc.

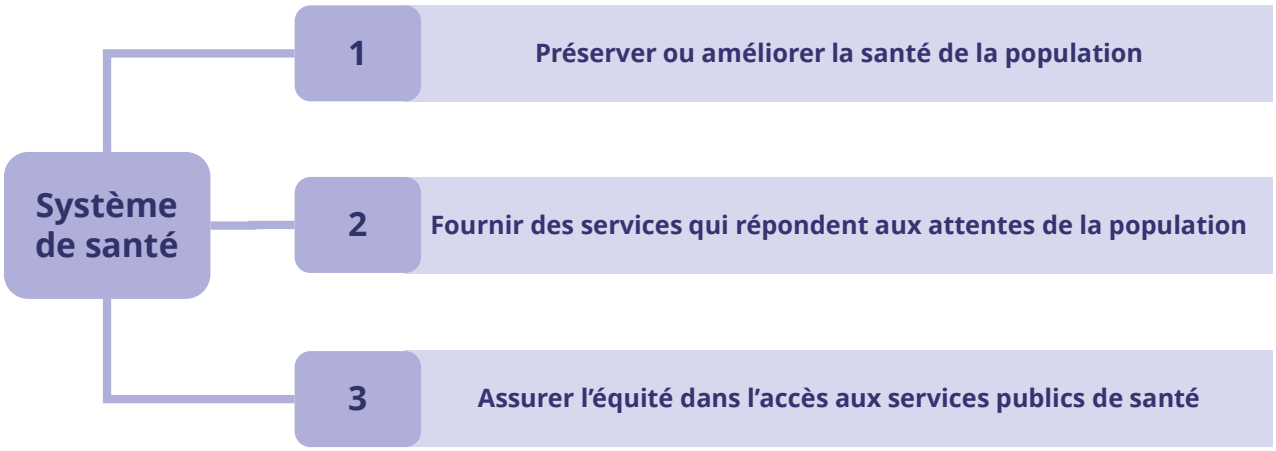
Objectifs du système de santé



13

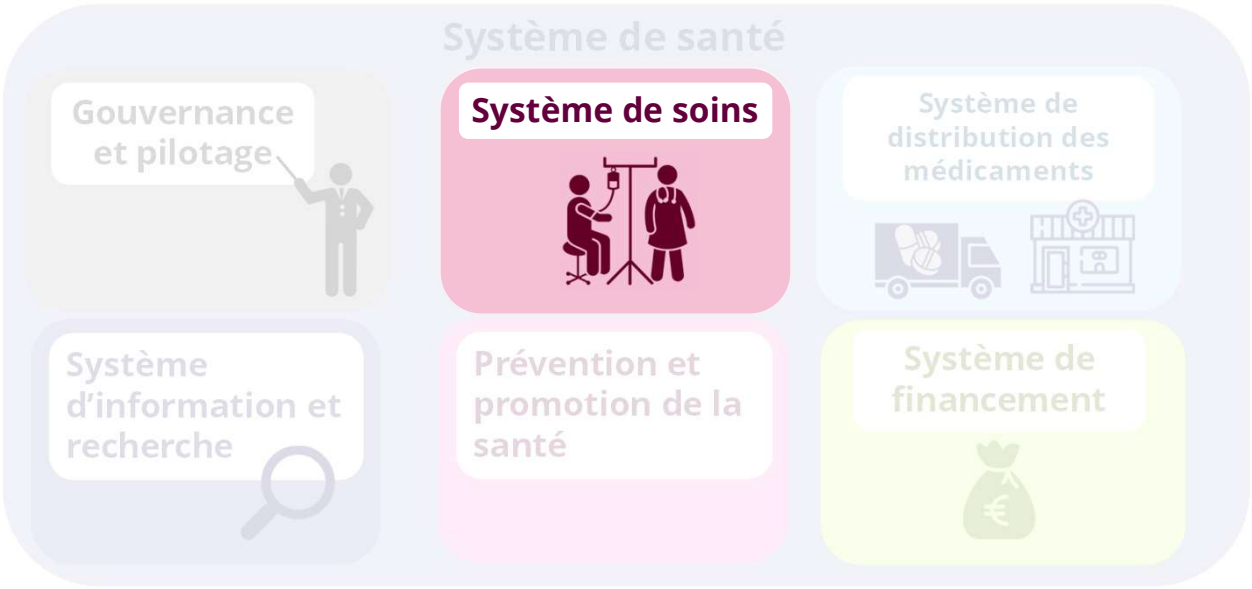
- **Assurer l'équité dans l'accès aux services publics de santé** : tout le monde doit pouvoir accéder à des soins adaptés à ses besoins, sans discrimination

Objectifs du système de santé



14

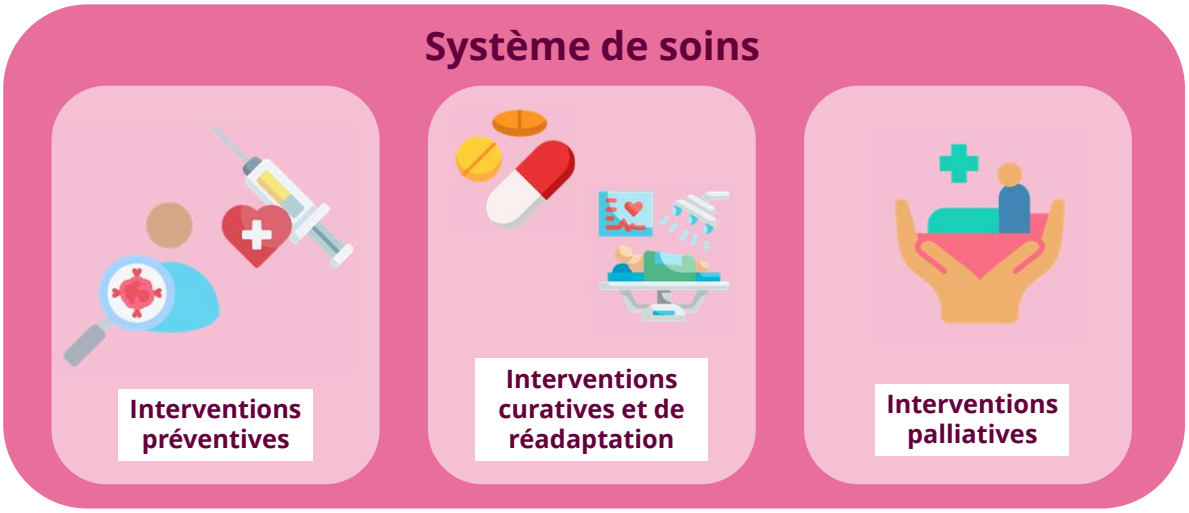
PARTIE 1 – Le système de soins



15

On va d'abord s'intéresser au système de soins.

Définition du Système de Soins



16

C'est quoi un « soin » ? : *de l'ancien français soign : « se soucier de, s'intéresser à »,* c'est l'ensemble des actions par lesquelles <u>on conserve ou on rétablit la santé</u>

Organisation mondiale de la santé (2000)
Le système de soins correspond à l'ensemble des services de santé qui ont pour principales fonctions la prestation d'interventions **préventives, curatives, et palliatives**, en réponse à des besoins spécifiques de santé des individus ou des populations.

Acteurs du système de soins



17

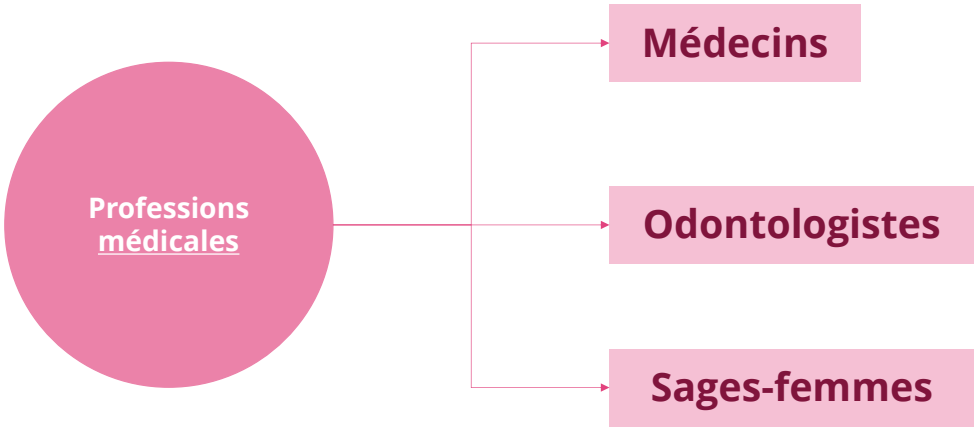


Code de la Santé publique

Les professions de santé se décomposent en trois catégories :

- Les professions **médicales**
- Les professions de la **pharmacie** et de la **physique médicale**
- Les professions d'**auxiliaires médicaux**

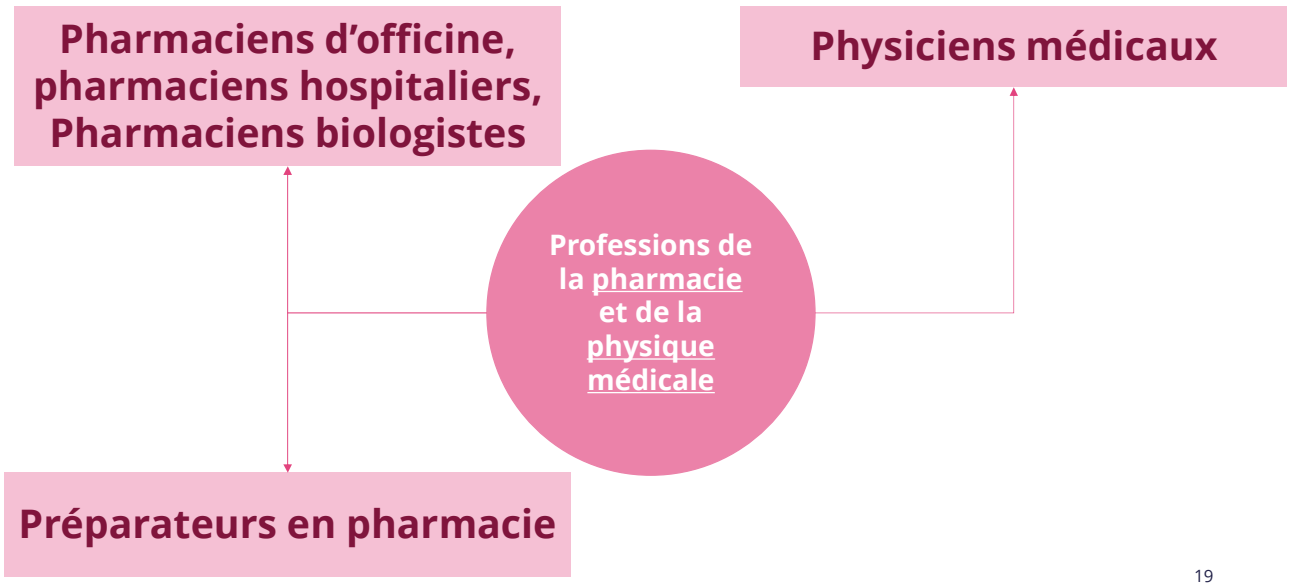
Professionnels de santé : Professions médicales



18

On compte trois professions médicales :
- Les médecins (toutes spécialités)
- Les odontologistes (dentistes)
- Les sages-femmes (maïeutique)

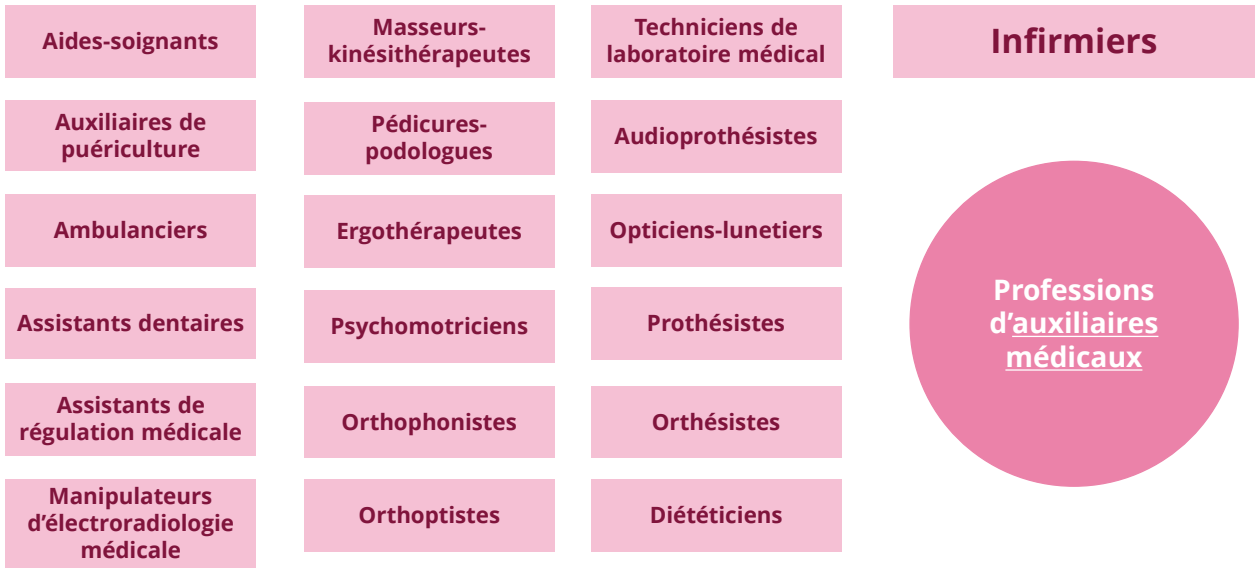
Professionnels de santé : Professions de la pharmacie et physique médicale



Dans cette catégorie, on a :

- Les pharmaciens (en officine, à l'hôpital, dans les laboratoires de biologie)
- Les préparateurs en pharmacie
- Les physiciens médicaux

Professionnels de santé : Professions d'auxiliaires médicaux

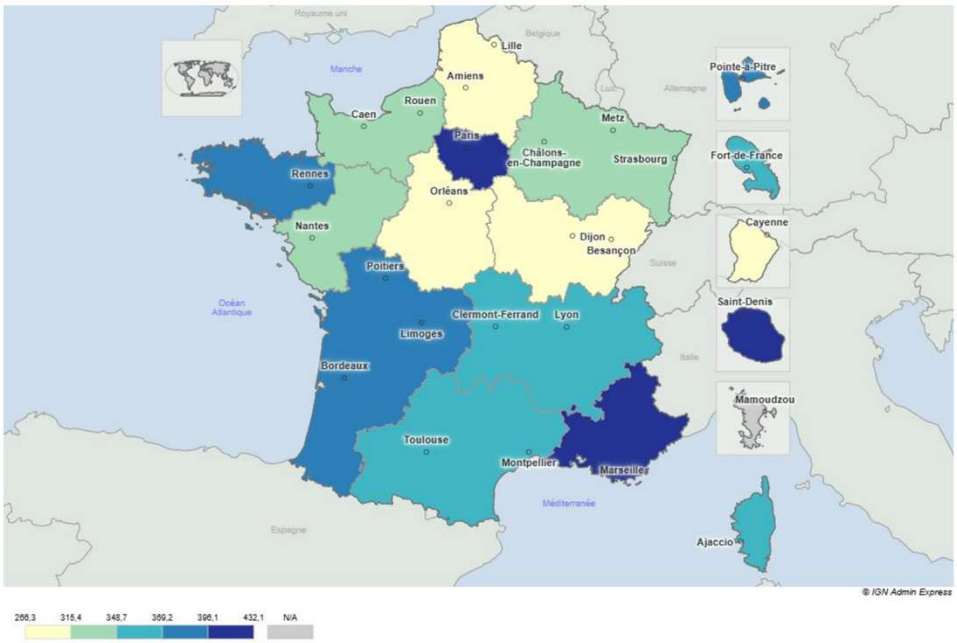


20

Dans les professions d'auxiliaires médicaux / paramédicaux, on a notamment les infirmiers, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, etc.

(Pas besoin de connaître la liste de tous ces professionnels par cœur)

Densités régionales des médecins en activité au 1er janvier 2026 (pour 100 000 habitants)



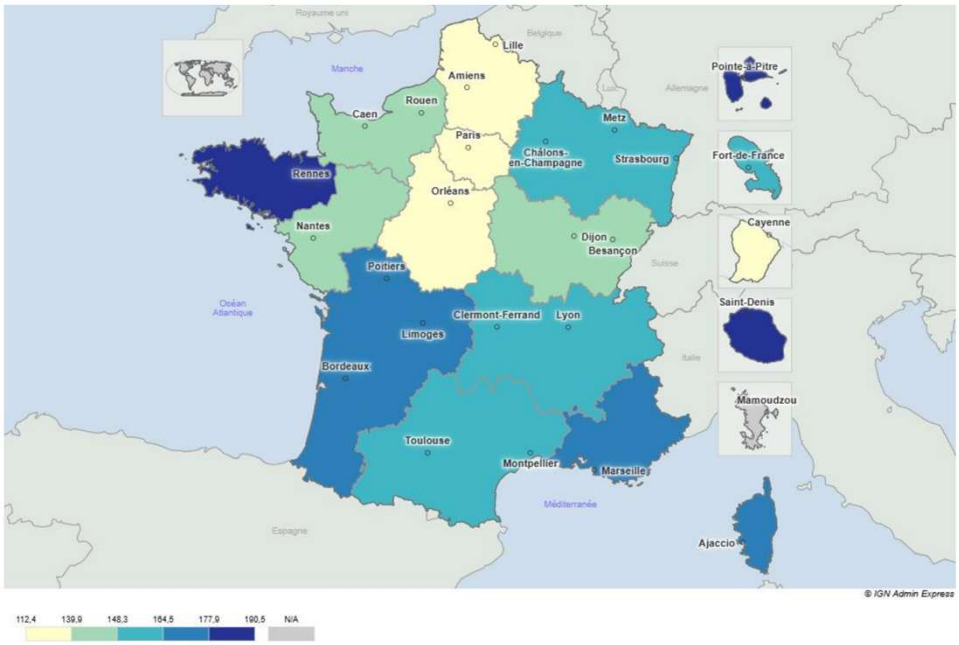
21

Chiffres sur la démographie médicale

On voit que l'Ile de France, la Réunion et la Provence-Alpes-Côte d'Azur sont les régions les plus dotées en médecins toutes spécialités confondues
Et les moins dotées sont le Centre-Val-de-Loire, les Hauts de France et la Guyane.

Source : Conseil national des médecins (https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/CNOM-ATLAS-DEMOGRAPHIE-2026-TOME-1.pdf)

Densités régionales des médecins généralistes en activité au 1er janvier 2026 (pour 100 000 habitants)



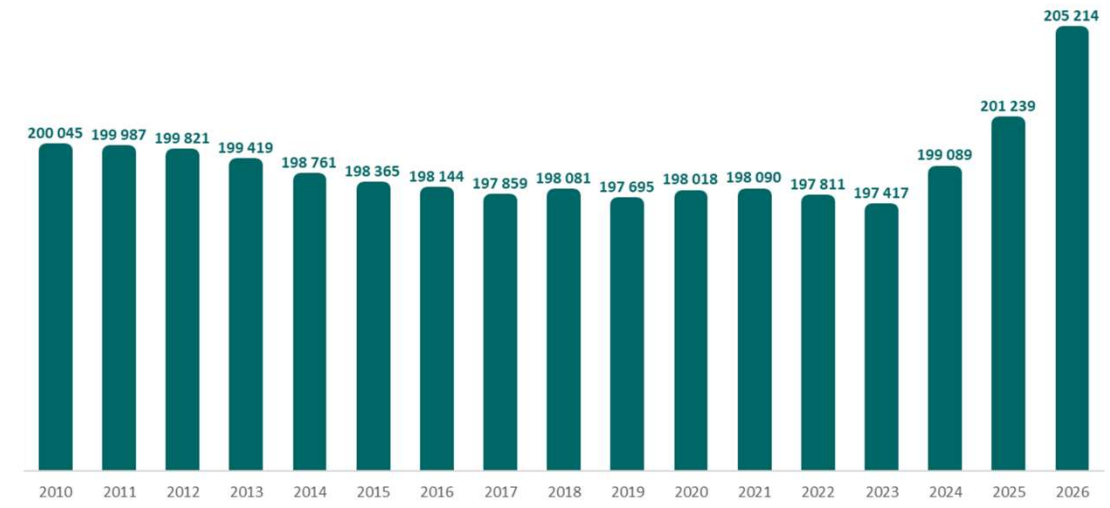
22

Chiffres sur la démographie médicale

Lorsqu'on regarde uniquement la densité de médecins généralistes, on voit que cette fois ci que l'Ile de France passe en dernier. L'Ile de France est donc à la fois un désert médical de médecins généralistes, et une région où il y a beaucoup de médecins mais surtout spécialistes.

Et parmi les plus dotées en médecins généralistes, on a la Bretagne.

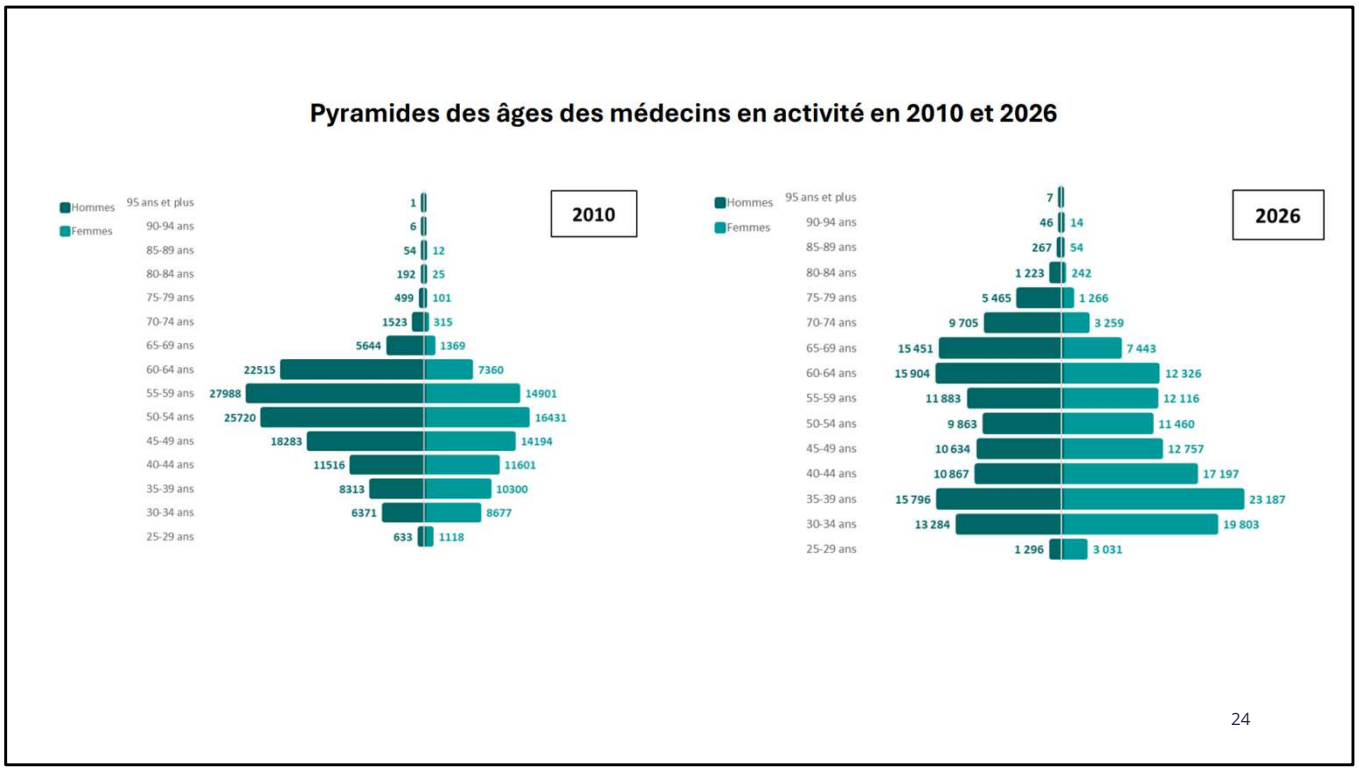
Source : Conseil national des médecins (https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/CNOM-ATLAS-DEMOGRAPHIE-2026-TOME-1.pdf)



Chiffres sur la démographie médicale

On assiste à une augmentation de l'effectif des médecins depuis 2010/

Source : Conseil national des médecins (https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/CNOM-ATLAS-DEMOGRAPHIE-2026-TOME-1.pdf)



Chiffres sur la démographie médicale

-Et on assiste à la fois à une féminisation de la profession, a un vieillissement des médecins et à une augmentation de la proportion de jeunes médecins

Source : Conseil national des médecins (https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/CNOM-ATLAS-DEMOGRAPHIE-2026-TOME-1.pdf)

565 553 infirmiers inscrits au tableau au 1er mars 2025 dont :

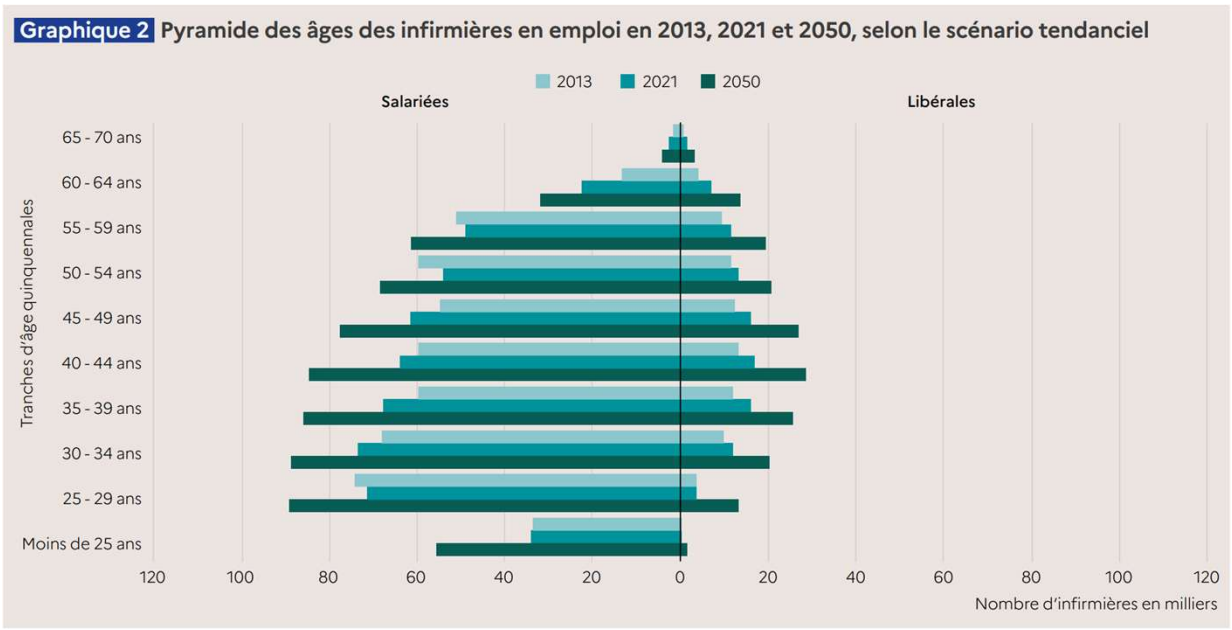
- 6 338 IBODE (Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d'État)
- 7 479 IADE (Infirmier Anesthésiste Diplômé d'État)
- 14 462 IPDE (Infirmier puériculteur Diplômé d'État)
- 2 367 IPA (Infirmier en Pratique Avancée)

25

Démographie des infirmiers

On a entre deux fois et trois fois plus d'infirmiers en France que de médecins

Source : Ordre national des Infirmiers (https://www.ordre-infirmiers.fr/l-ordre-national-des-infirmiers-publie-une-nouvelle-etude-sur-la-demographie-de-la-profession-et)

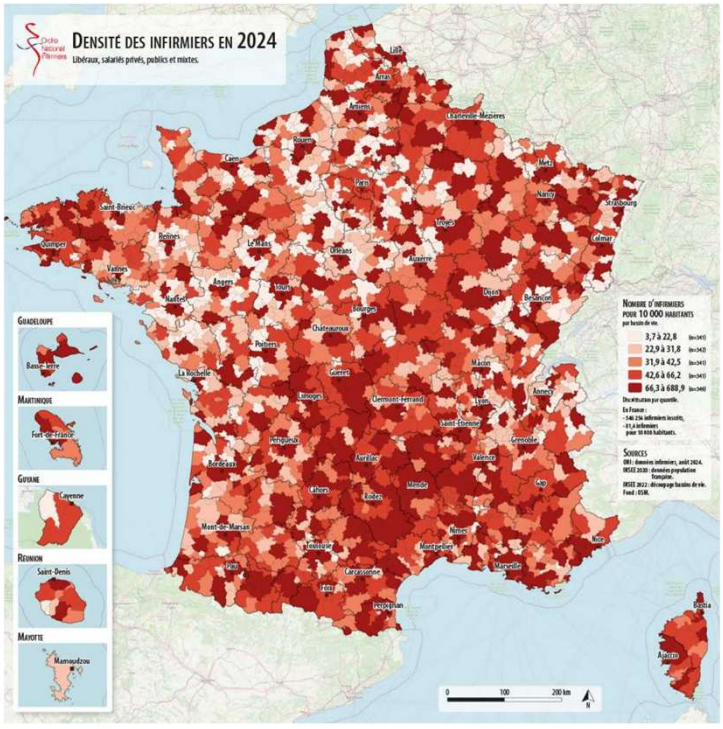


26

Démographie des infirmiers

Globalement, entre 2013 et 2021, les chiffres sont stables.
(Les chiffres de 2050 sont des projections).

Source : DREES (https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2024-12/ER1319EMB.pdf)

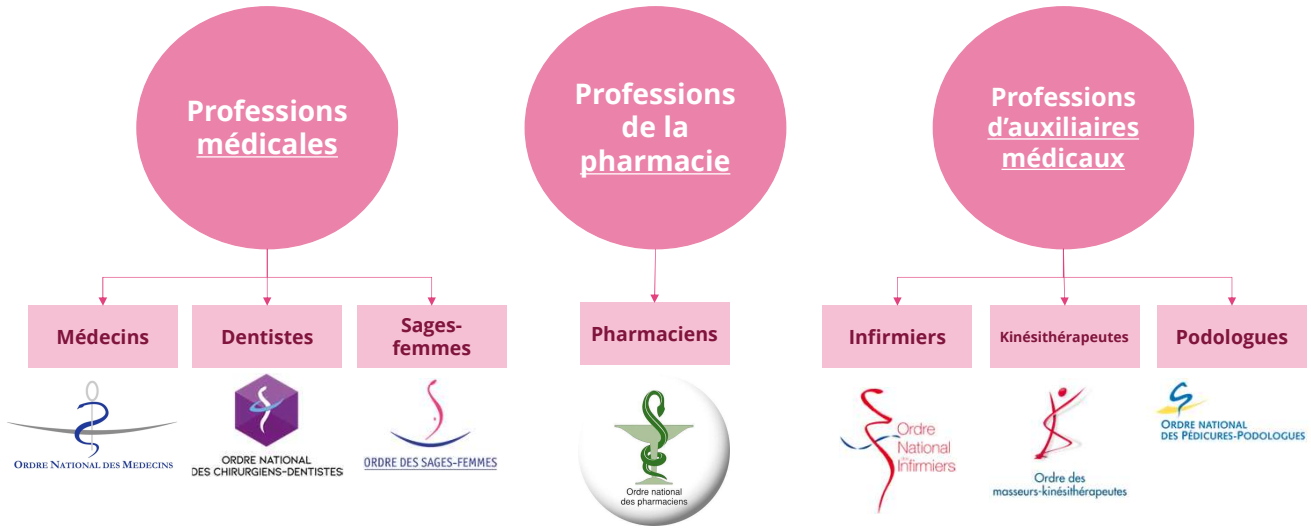


27

Démographie des infirmiers

Source : Ordre national des infirmiers (https://www.ordre-infirmiers.fr/system/files/inline-files/Analyse%20et%20commentaires%20de%20la%20production%20cartographique%202024%20de%20l%E2%80%99Ordre%20national%20des%20infirmiers%202.pdf)

Professionnels de santé : Ordres professionnels



28

On compte 7 ordres professionnels.

Professionnels de santé : Ordres professionnels

Médecins	Dentistes	Sages-femmes	Pharmaciens	Infirmiers	Kinésithérapeutes	Podologues







29

Les missions des ordres sont les suivantes :

- **Régulation de l'accès à la profession** (délivrance du permis d'exercer) et suivi du **Tableau de l'Ordre :** Appartenance à l'ordre de sa profession obligatoire pour pouvoir exercer
- Contribution et suivi de la **formation continue**
- Promotion de la profession et fonction de **représentation**
- Fonction **juridictionnelle** et arbitrale (relative à la **responsabilité disciplinaire** des professionnels inscrits)

Modes de rémunération des professionnels



Mode d'exercice salarié

Paiement à l'heure



Mode d'exercice libéral

Paiement à l'acte

30

Les professionnels de santé peuvent avoir deux types de rémunération :

- Soit un mode d'exercice **salarié** : ils sont payés chaque heure le même montant
- Soit un mode d'exercice **libéral** : ils sont payés à l'acte selon des tarifs déjà établis

Certains ont une activité à la fois salariée et libérale.

Les deux modes d'exercices ont leurs avantages et leurs inconvénients.

Lieux de soins



Etablissements de santé



Structures médico-sociales



Soins de ville

31

Tous ces professionnels de santé exercent dans 3 types de lieux de soins :

- Les établissements de santé
- Les structures médico-sociales
- En ville

Lieux de soins : Etablissements de santé



Etablissements de santé

32



Code de la santé publique

Un établissement de santé a vocation à :

- assurer le **diagnostic**, la **surveillance** et le **traitement** des personnes malades, des blessés, et des femmes enceintes
- dispenser des **soins**, avec **hébergement ou non**, sous forme **ambulatoire ou à domicile**
- participer à la **coordination des soins** avec les professionnels de santé exerçant en ville et les services médicosociaux

Lieux de soins : Etablissements de santé



Etablissements de santé

Etablissements publics

- **Centres hospitaliers régionaux (CHR) et centres hospitaliers universitaires (CHU)**
- **Centres hospitaliers**
- **Hôpitaux de proximité**
- **Etablissements publics spécialisés**

33

Ce qu'il faut comprendre, c'est que les établissements publics sont contrôlés **par l'Etat**.
Ils assurent des **missions de service public**.

Il en existe plusieurs types selon leur taille et leurs missions :

- Centres hospitaliers régionaux dont centres hospitaliers universitaires
- Centres hospitaliers
- Hôpitaux de proximité
- Etablissements publics spécialisés



Centre hospitalier universitaire (CHU)



Hôpital de proximité



Etablissement public spécialisé

34

Quelques exemples d'établissements publics.

Lieux de soins : Etablissements de santé



Etablissements de santé

Etablissements publics

- Centres hospitaliers régionaux (CHR) et centres hospitaliers universitaires (CHU)
- Centres hospitaliers
- Hôpitaux de proximité
- Etablissements publics spécialisés

Etablissements privés

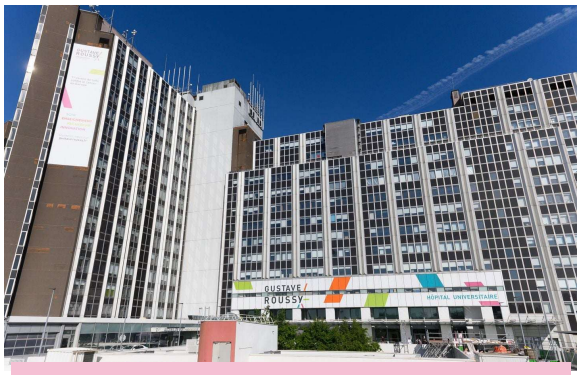
- Etablissements privés à but non lucratif dont les établissements privés d'intérêt collectif (ESPIC)
- Etablissements privés à but lucratif (cliniques)

35

Les établissements privés n'appartiennent pas à l'Etat, mais à des structures **privées** (mutuelles, associations…). Il y en a deux types :

- établissements à but non lucratif dont les établissements de santé privés d'intérêt collectifs (ESPIC) :
Ils assurent des missions de service public comme les établissements publics .
ex : centres de lutte contre le cancer

- établissements à but lucratif : cliniques privées
Ils n'assurent sans mission de service public à assurer.



Etablissement privé d'intérêt collectif (ESPIC)

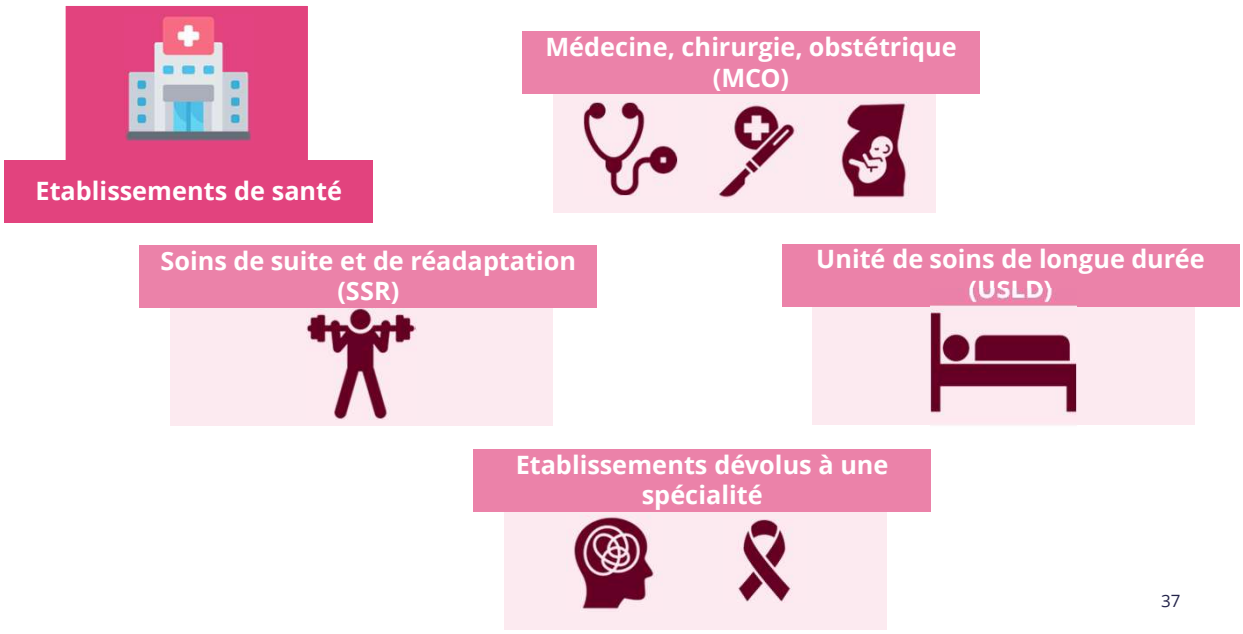


Clinique

36

Quelques exemples d'établissements privés.

Etablissements de santé : Types de soins



Soins aigus (courte durée) : soins de **Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO)**

Soins de suite et de réadaptation (SSR) : accueillent les patients pour une convalescence

Unités de soins longue durée (USLD) : accueillent des personnes dont l'état de santé nécessite une surveillance médicale constante

Etablissements dévolus à une spécialité :
Exemples : santé mentale = hôpital psychiatrique, centre de lutte contre le cancer (CLCC)

Lieux de soins : Structures médico-sociales



38

Les structures médico-sociales accueillent les **personnes en situation de vulnérabilité, de handicap, de perte d'autonomie ou avec des difficultés sociales**.
Elles font du soin, mais accompagnent aussi les personnes dans leur autonomie, leur besoins sociaux, leur projet de vie.

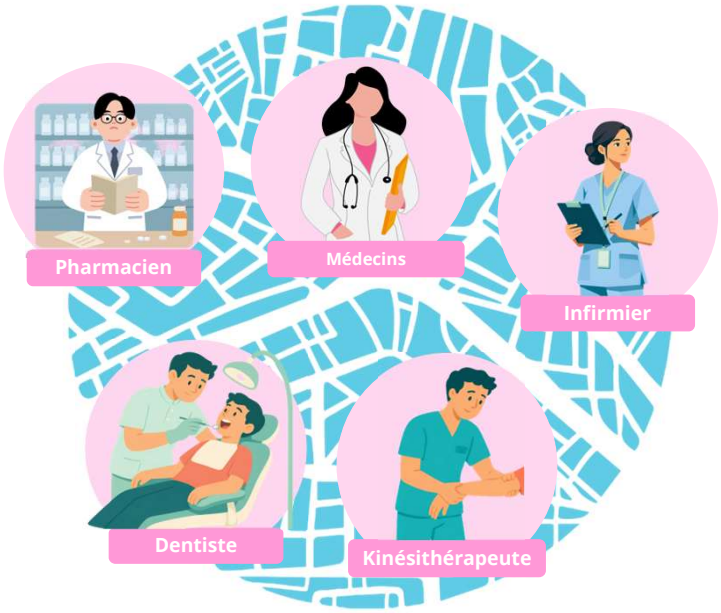
Exemples de structures médico-sociales :

Pour les personnes âgées :
- EHPAD
- Résidences autonomie
- Services d'aide et d'accompagnement à domicile

Pour les personnes en situation de handicap :
- Institut médico-éducatif
- Maison d'accueil spécialisée
- Foyer d'accueil médicalisé
- Etablissement et service d'accompagnement par le travail

(Pas besoin de retenir toutes les structures, comprendre le principe)

Lieux de soins : Soins de ville





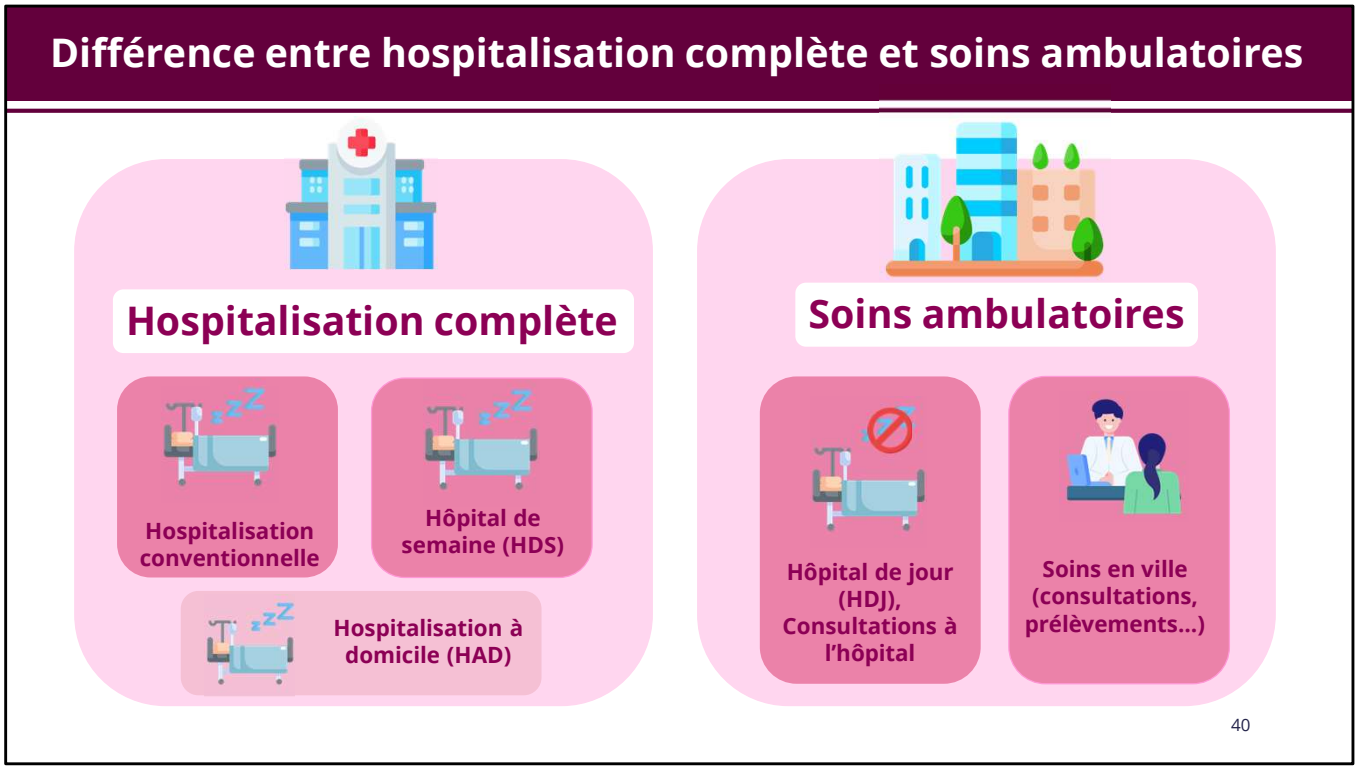
Soins de ville

Consultation d'un professionnel de santé exerçant en ville

39

Les soins de ville correspondent aux soins qui sont réalisés en dehors des établissements de santé et des structures médico-sociales.

Par exemple : toutes les consultations des professionnels de santé (médecins, infirmiers, orthophonistes…) dans les cabinets comme à domicile, les pharmaciens d'officine…



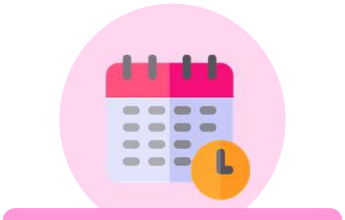
Il existe plusieurs types de soins en fonction des endroits où on peut se faire soigner :

Hospitalisation complète : les patients dorment à l'hôpital
- en **hospitalisation conventionnelle**
- en **hôpital de semaine** (HDS)

- /!\ L'**hospitalisation à domicile** (HAD) est un cas particulier d'hospitalisation complète mais à domicile

Soins ambulatoires : les patients ne dorment pas à l'hôpital ni dans une autre structure de soins : ils y restent quelques heures, le temps de faire le soin, puis rentrent chez eux.
- Soins hospitaliers en **hôpital de jour** (HDJ) : les patients viennent quelques heures à l'hôpital (une journée ou une demi-journée) pour réaliser des examens complémentaires ou recevoir un traitement de dispensation hospitalière, mais ne dorment pas à l'hôpital
- Consultations ou examens à l'hôpital sans nuitée.
- Soins en **ville** : consultations effectuées dans les cabinets de ville, les dispensaires, les centres de soins, mais aussi à l'hôpital et à domicile (visites à domicile), prélèvements analysés dans des laboratoires de ville

Modalités de prise en charge



Soins programmés



Soins non programmés



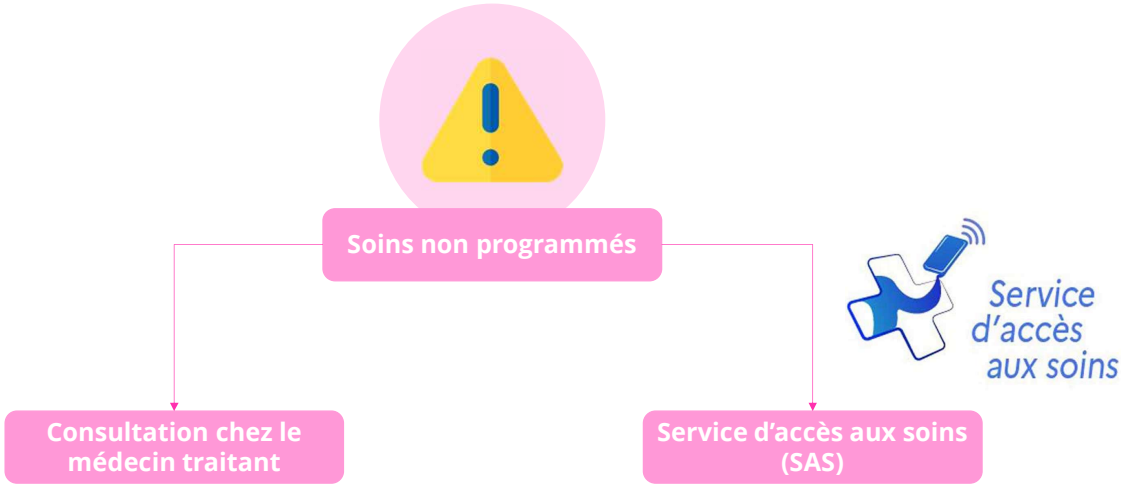
Urgences vitales

41

Il existe plusieurs modalités de prise en charge selon l'urgence de la demande de soin:

- **Soins programmés** : pas d'urgence vitale, consultation ou chirurgie attendues et programmée. Exemple : Amygdalectomie programmée, consultation de suivi chez le cardiologue
- **Urgences vitales** : nécessité de prise en charge immédiate (SAMU, urgences hospitalières). Exemple : AVC, infarctus
- Entre les deux, on a les **soins non programmés** : nécessité de prise en charge rapide mais sans urgence vitale. Exemple : angine

Modalités de prise en charge : soins non programmés



42

Les soins non programmés, dans le meilleur des cas, sont pris en charge par le médecin traitant.

Dans le cas où il n'est pas disponible ou pour les patients n'ayant pas de médecin traitant, un dispositif a été créé pour éviter la surcharge des urgences : le service d'accès aux soins (SAS).

Comment fonctionne le service d'accès aux soins ?
Le patient qui a besoin d'une consultation appelle le 15. Il sera ensuite mis en contact avec un régulateur qui le redirigera vers le médecin régulateur du SAS. Ce médecin a accès aux agendas de médecins du territoire. Il proposera alors au patient une consultation dans les 24-48h.

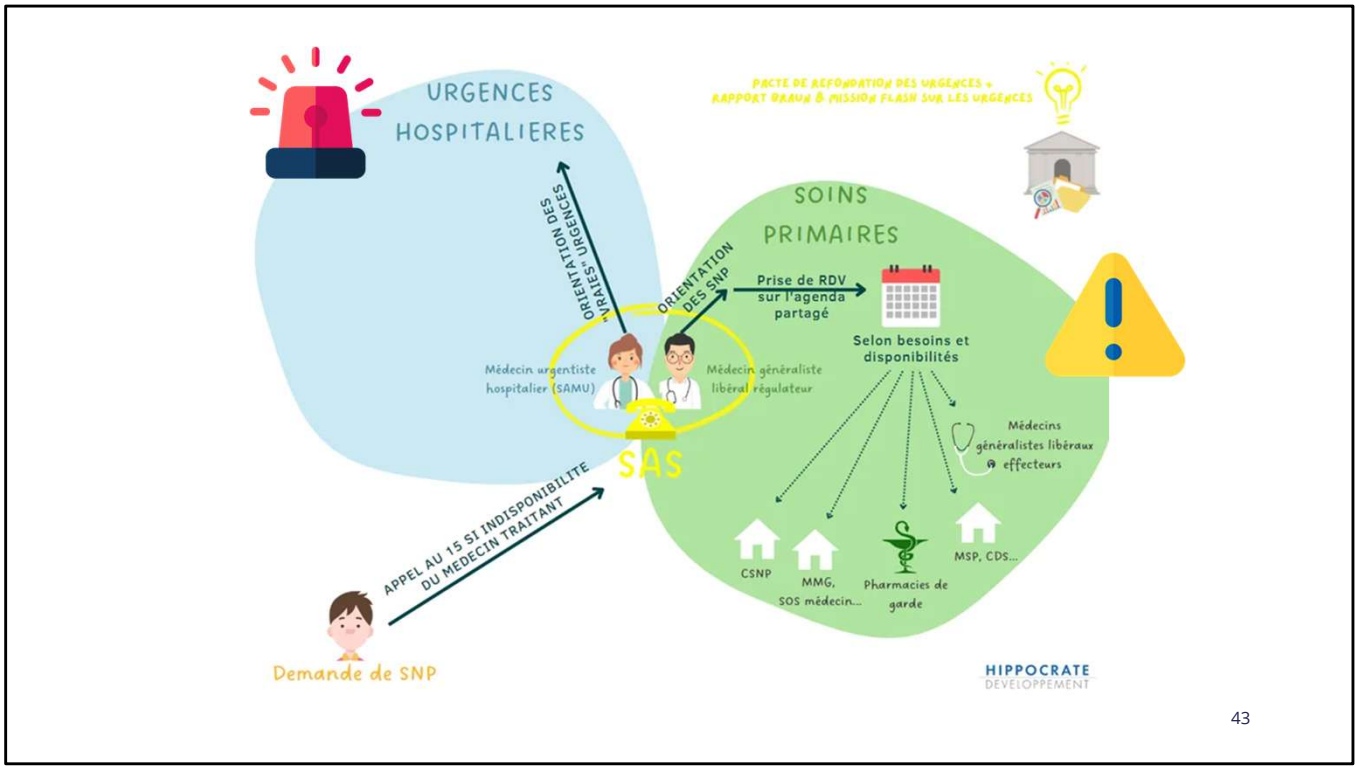
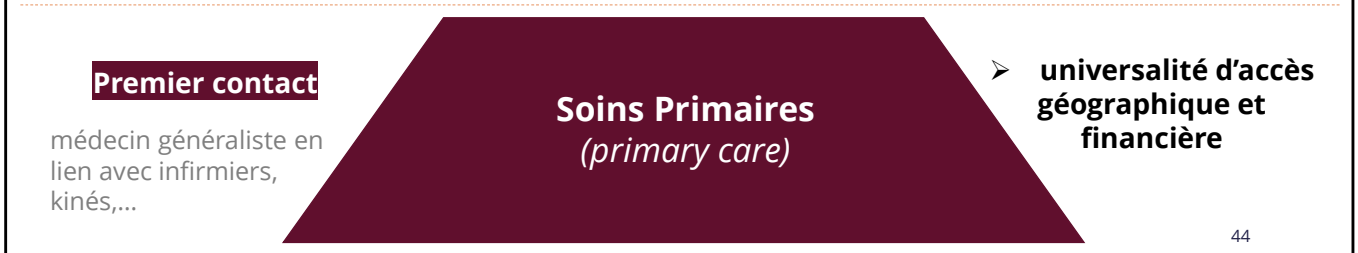


Schéma du Service d'accès aux soins.

Hiérarchie des soins : Soins primaires

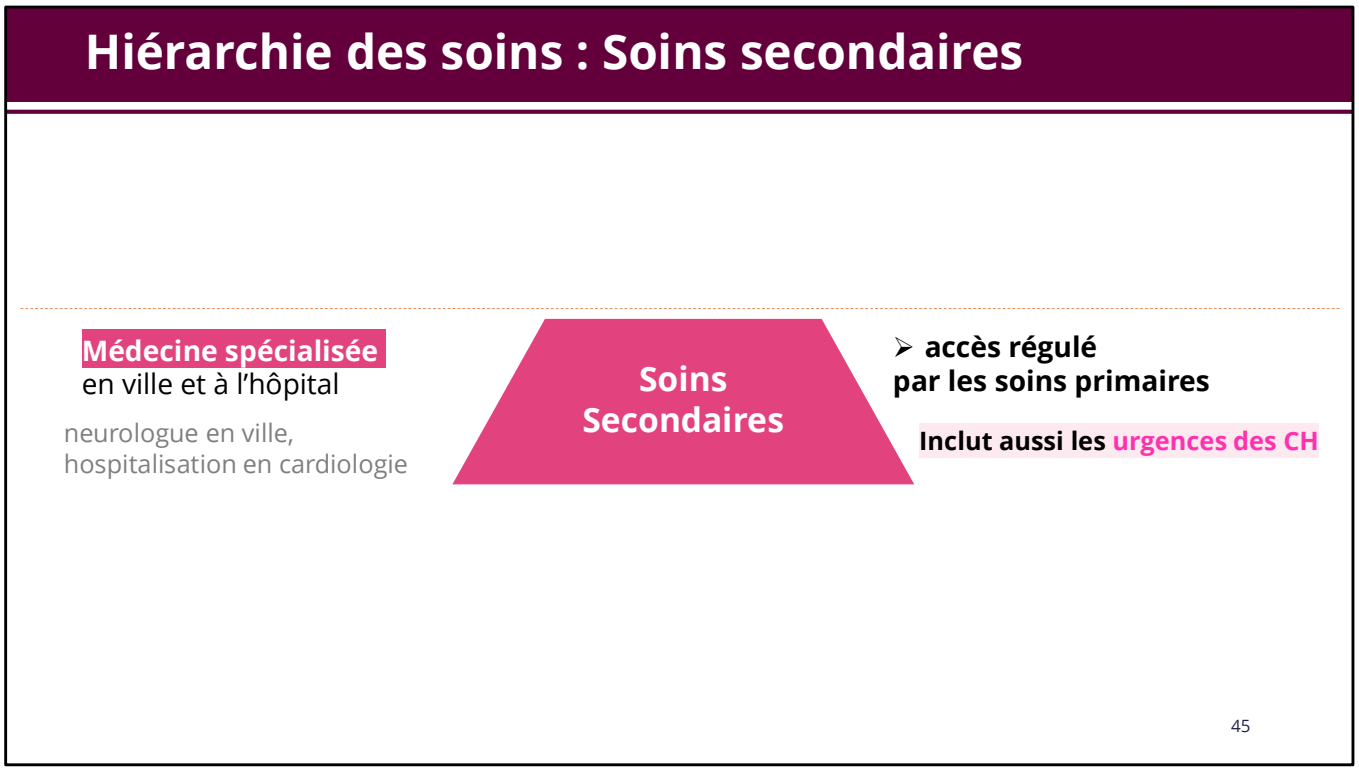


Soins primaires

Organisation mondiale de la santé (1978)
« les soins primaires sont les **soins de santé essentiels** universellement accessibles à tous les individus et à toutes les familles de la communauté par les moyens qui sont acceptables, avec leur pleine participation et à un cout abordable pour la communauté du pays »

Les principaux acteurs sont : les médecins généralistes, les infirmiers, les pharmaciens d'officine, les chirurgiens-dentistes, les masseurs-kinésithérapeutes, les sages-femmes, exerçant en ville.

Ils s'appuient sur une infrastructure légère : cabinet privé, dispensaire, centre de santé, maison de santé ou soins à domicile.



Soins secondaires

Ils sont définis comme « la prestation de soins médicaux par des **spécialistes qui n'ont généralement pas de premier contact avec les patients** »

Ils interviennent quand un problème de santé nécessite une prise en charge qui dépasse les ressources habituelles des soins de premier recours.

Par exemple :

- Consultation chez un cardiologue
- Hospitalisation en dermatologie
- Urgences hospitalières

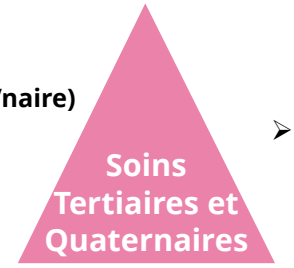
Les soins de deuxième recours peuvent être réalisés en **ville** ou à **l'hôpital**.

Hiérarchie des soins : Soins tertiaires et quaternaires

Médecine de haute technologie

Voir traitements expérimentaux (IVnaire)

CHU,
Centres de lutte contre le cancer,
Centres de référence maladie rare



➢ **accès limité aux cas spécifiques**

46

Soins tertiaires

Ils correspondent à des **prises en charge complexes** qui nécessitent une **organisation, des compétences, des équipements spécialisés**.

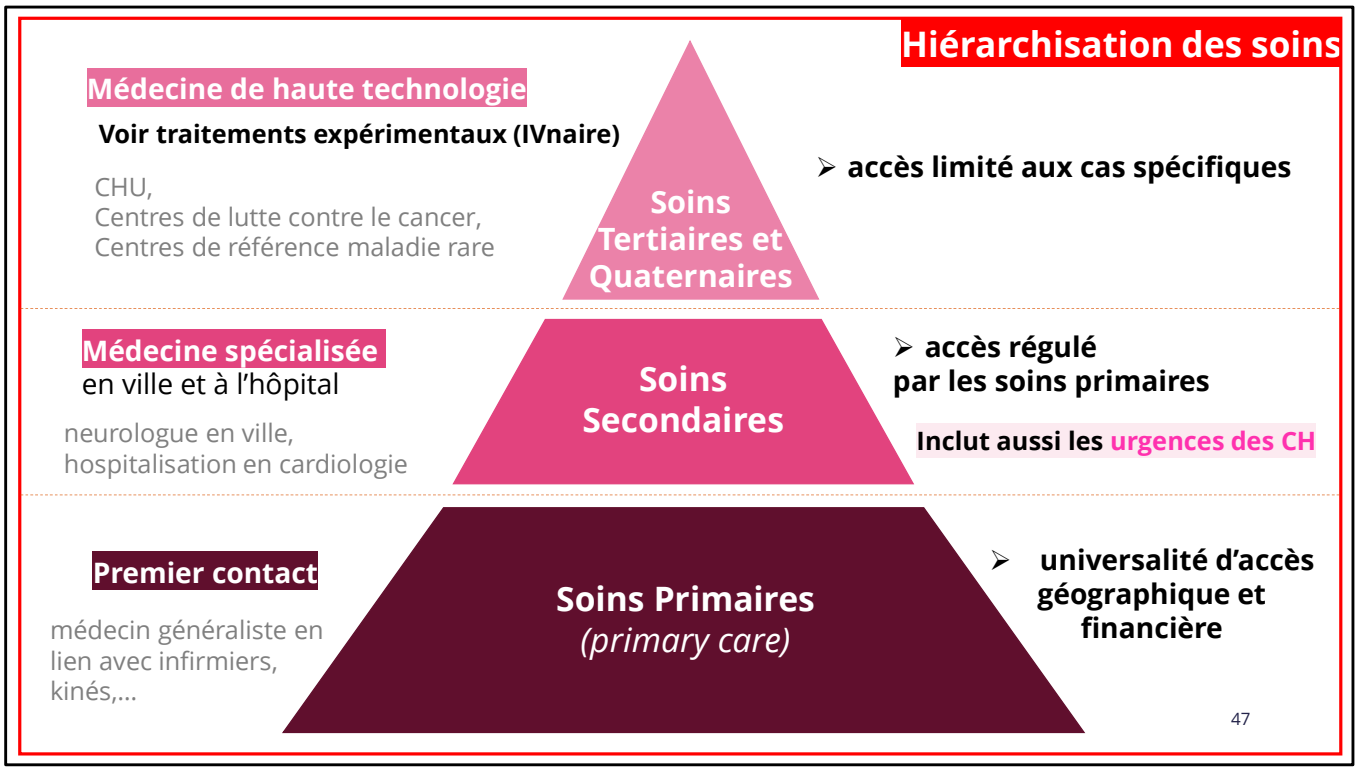
Par exemple :
- Chirurgie complexe
- Prise en charge d'une maladie rare dans un centre expert
- Traitements spécialisés de certains cancers

Ils sont assurés par des établissements de référence ou des équipes spécialisées.

Soins quaternaires

Ils correspondent à des prises en charge encore plus spécialisées et inhabituelles.

Par exemple :
- Des traitements / procédures expérimentales (recherche médicale)
- Chirurgies rares et ultra-spécialisées


Hiérarchisation des soins
Médecine de haute technologie
Voir traitements expérimentaux (IVnaire)
CHU,
Centres de lutte contre le cancer,
Centres de référence maladie rare
Soins Tertiaires et Quaternaires
➢ accès limité aux cas spécifiques
Médecine spécialisée
en ville et à l'hôpital
neurologue en ville,
hospitalisation en cardiologie
Soins Secondaires
➢ accès régulé par les soins primaires
Inclut aussi les urgences des CH
Premier contact
médecin généraliste en lien avec infirmiers, kinés,…
Soins Primaires
(primary care)
➢ universalité d'accès géographique et financière
47

Définition du parcours de soins coordonné

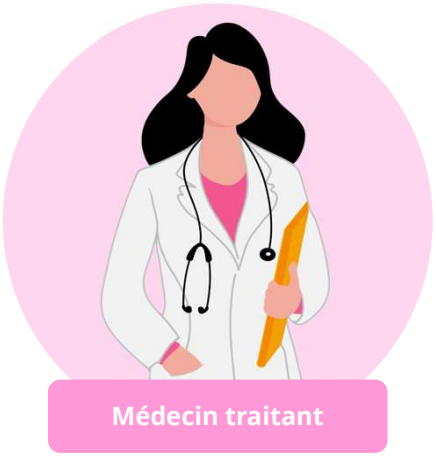


48

Le parcours de soins coordonné correspond à l'enchainement des consultations, examens, traitements, et prises en charge médicales d'un patient ayant une maladie, avec comme objectif de garantir une prise en charge cohérente et coordonnée.

L'acteur principal de ce parcours de soins coordonné est le **médecin traitant**.

Parcours de soins : Médecin traitant



Médecin traitant

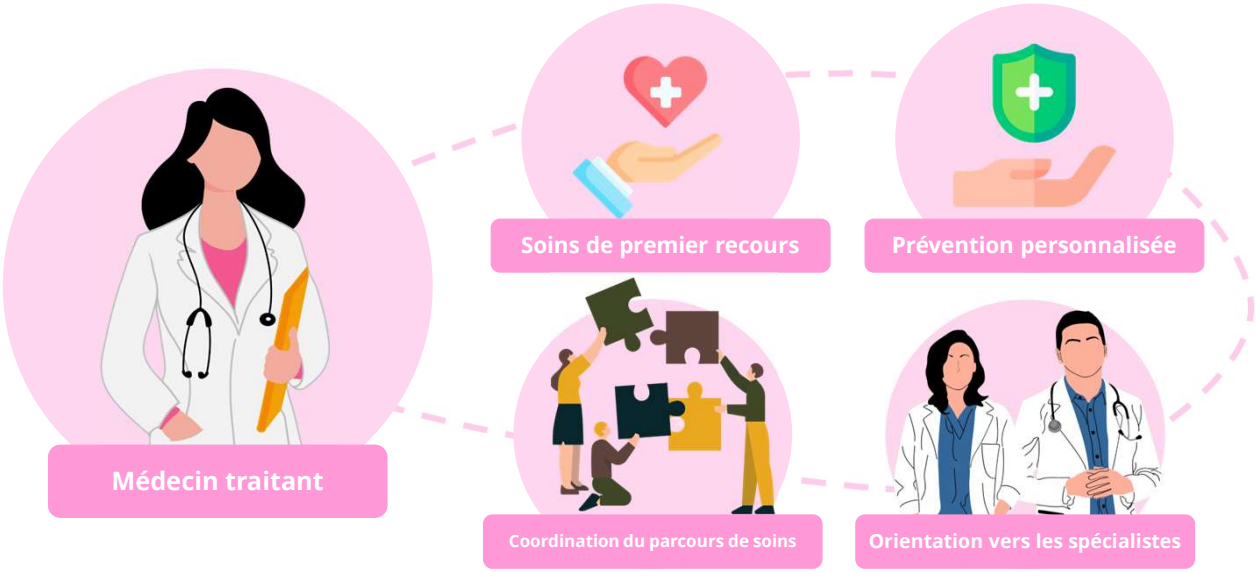
Médecin généraliste ou médecin spécialiste
Exerçant en ville ou à l'hôpital

49

Le médecin traitant peut être un **médecin généraliste** ou **spécialiste** (même hospitalier).

Tous les assurés / ayants-droits de plus de 16 ans doivent déclarer à leur caisse primaire d'assurance maladie leur médecin traitant.

Parcours de soins coordonné : Médecin traitant

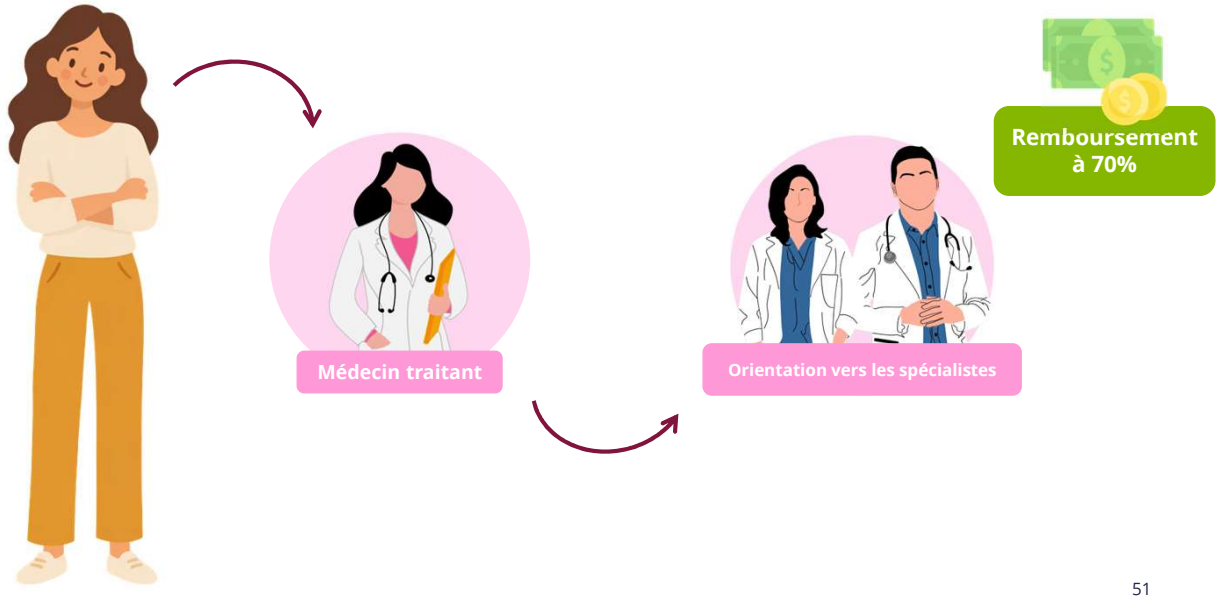


50

Le médecin traitant doit :

- Assurer les **soins de premiers recours** et la **permanence des soins**
- Assurer une **prévention personnalisée**
- **Orienter** vers les spécialistes
- **Coordonner** et suivre le patient dans son parcours de soins
- Etablit le protocole de soins dans les affections de longue durée (ALD)

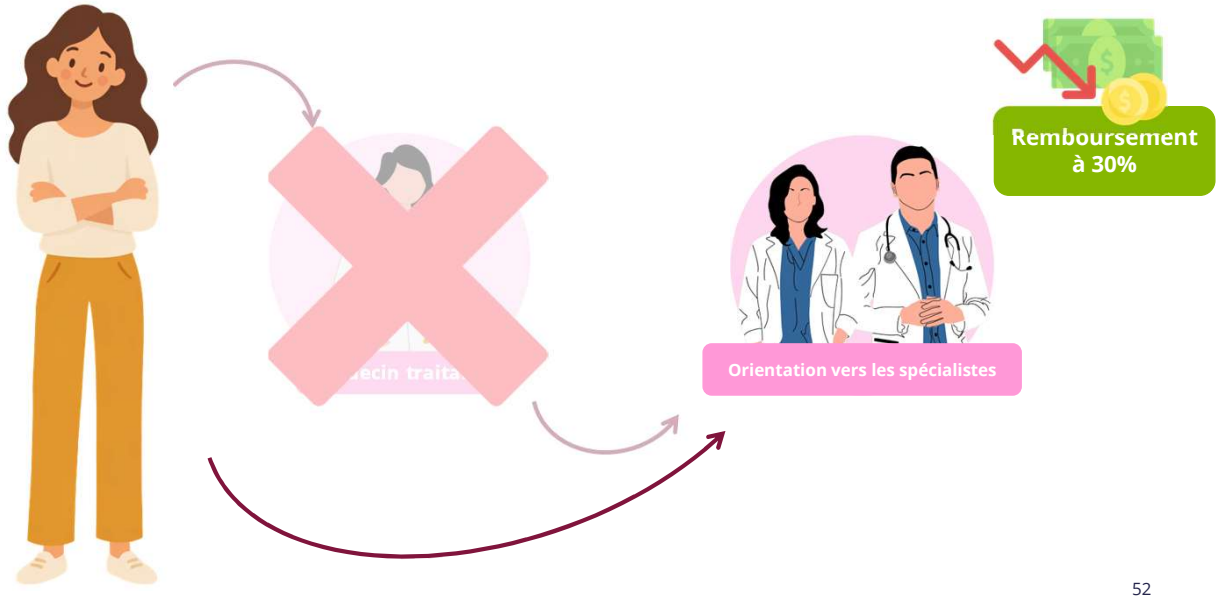
Parcours de soins coordonné



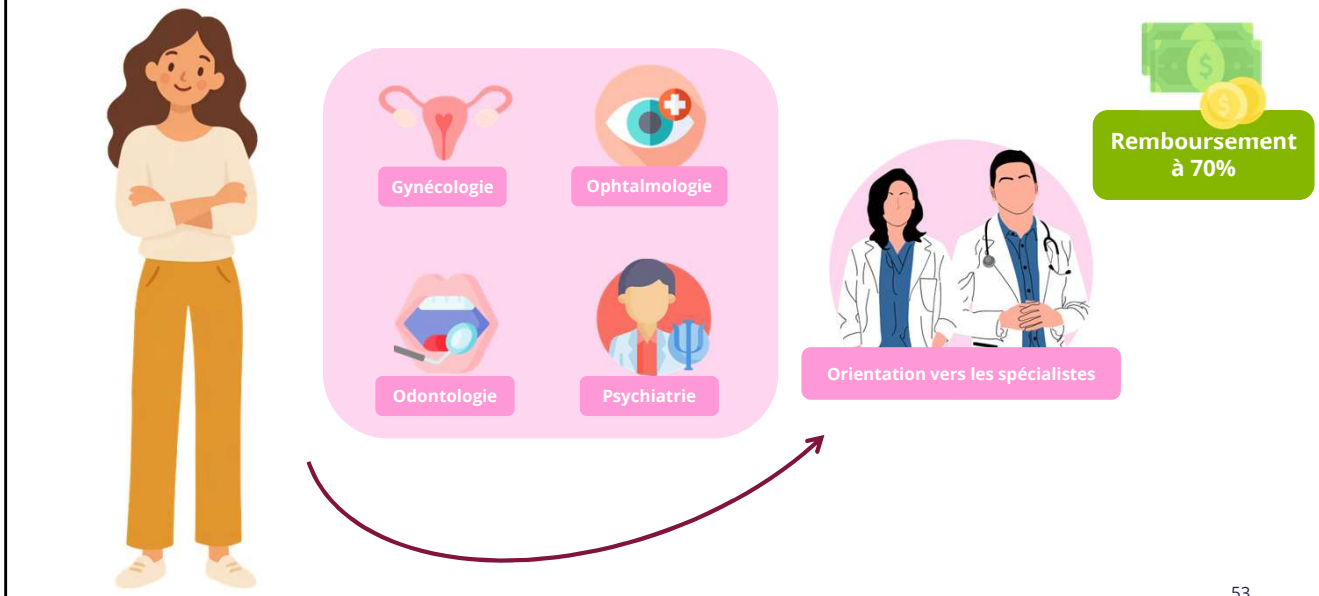
51

Qu'est-ce que ça change financièrement pour le patient d'avoir un parcours de soins coordonné ?
Être adressé à un spécialiste par le médecin traitant permet d'avoir un remboursement de l'Assurance maladie au meilleur taux de la consultation du spécialiste.

Sans parcours de soins coordonné



Exceptions au parcours de soins coordonné : les spécialités à part

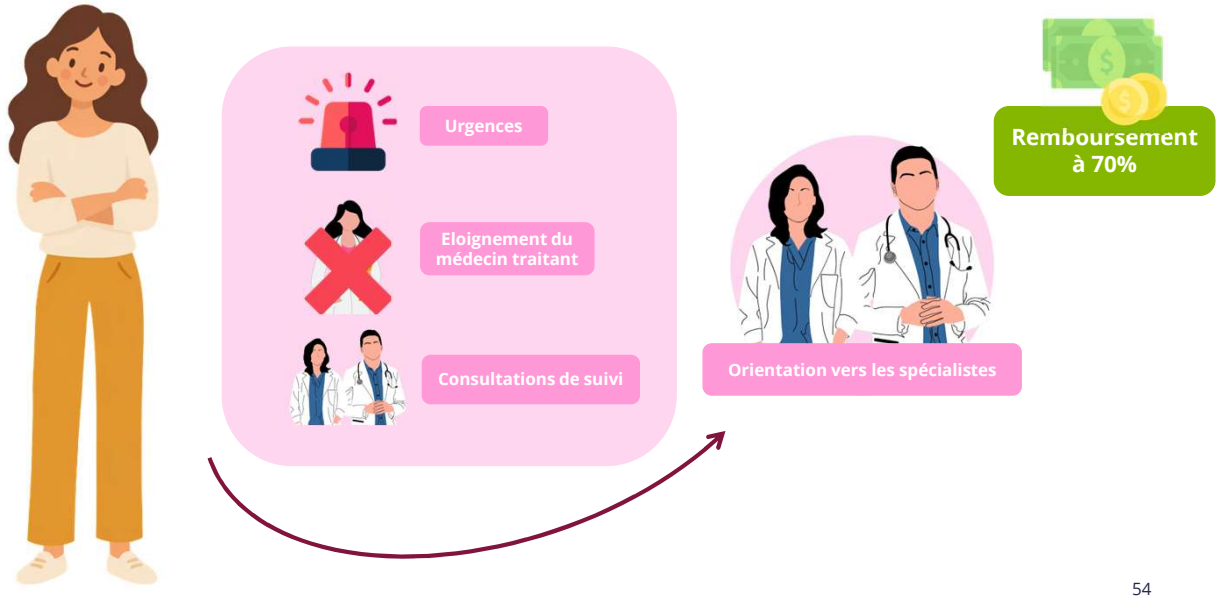


Il existe plusieurs exceptions au parcours de soins coordonné.

Accès direct spécifique pour certaines spécialités :
- Gynécologues
- Stomatologues
- Ophtalmologues
- (neuro)psychiatre pour les 16-25 ans

Même si accès direct, médecin traitant à déclarer quand même pour être mieux remboursé !

Exceptions au parcours de soins coordonné : les autres situations



54

Adressage pas nécessaire dans les cas suivants :

- pour les consultations de suivi avec un spécialiste qui connait le dossier
- pour les urgences
- En cas d'éloignement géographique (« hors résidence »)

Parcours de santé



55

Le parcours de santé est différent du parcours de soins.

Parcours de santé



56

Le parcours de santé est **plus large** que le parcours de soins : il l'englobe, et contient également la **prise en charge médico-sociale** (maintien de l'autonomie, EHPAD et structures médico-sociales) et **sociale** (accès aux droits, logement, mobilité, vie quotidienne).

Modes d’exercice coordonnés en ville



Equipes de soins primaires



Maison de santé pluriprofessionnelle



Centres de santé



Communauté professionnelle de santé

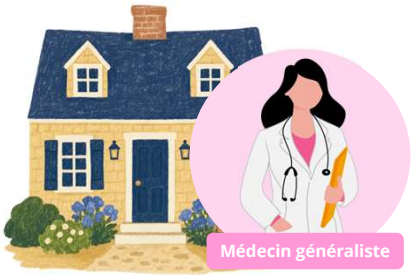
57

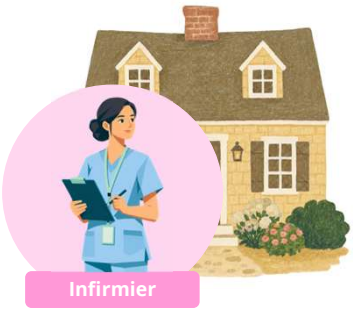
Il existe plusieurs modes d’exercice coordonnés en ville.

Equipes de soins primaires



Equipes de soins primaires







58

Une **équipe de soins primaires** (ESP) réunit les professionnels de santé de premier recours qui souhaitent coordonner leurs pratiques autour d'une population ou d'un projet commun. Chacun continue d'exercer dans sa propre structure / son propre cabinet.

Centres de santé (CDS)



Centres de santé



Mode d'exercice : salarié

59

Les **centres de santé** (CDS) sont des structures qui réunissent plusieurs professions médicales et paramédicales qui travaillent ensemble. Les professionnels sont généralement salariés.

Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP)



Maison de santé pluriprofessionnelle



Mode d'exercice : libéral

60

Les **maisons de santé pluriprofessionnelles** (MSP) sont des structures qui réunissent plusieurs professions médicales et paramédicales qui travaillent ensemble. Les professionnels sont généralement libéraux.

Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)



Communauté professionnelle de santé



61

Les **communautés professionnelles territoriales de santé** (CPTS) sont des structures où les professionnels de santé d'un territoire se réunissent autour d'un projet de santé. Attention, **ce ne sont pas des structures de soins**, mais des structures de coordination locales :

- entre les différents professionnels de santé du territoire
- entre les professionnels de la ville et des hôpitaux et structures médico-sociales

Leurs missions sont :

- Faciliter l'accès aux soins : par exemple, permettre à la population du territoire d'avoir accès à un médecin traitant
- Créer et organiser des parcours complexes entre la ville et l'hôpital
- Mettre en place des actions de prévention
- Réagir en cas de crise sanitaire
- Accompagner les professionnels de santé du territoire (pour l'installation par exemple)
- Améliorer la qualité et la pertinence des soins en ville

Outils numériques de coordination



DMP

MON ESPACE SANTÉ



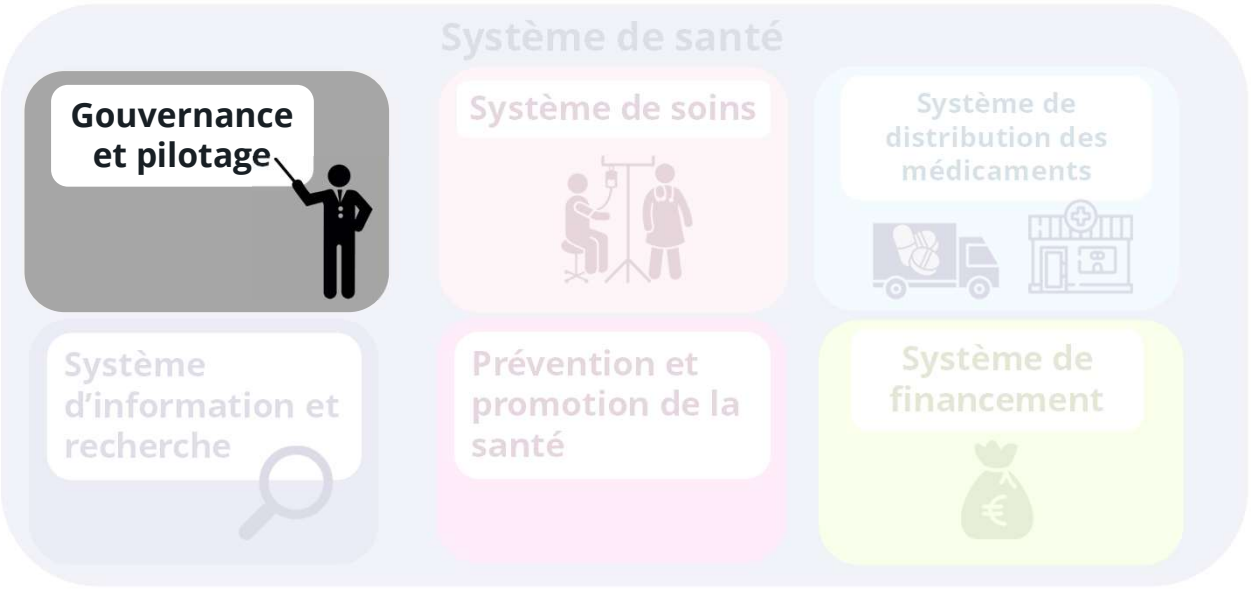
MSSanté
Système de messageries sécurisées, données protégées.

62

Il existe plusieurs outils numériques qui facilitent la coordination entre les professionnels de santé.

Le plus important est le DMP (dossier médical partagé) / Mon Espace Santé : c'est un carnet de santé numérique.

PARTIE 2 – L'administration / pilotage



63

Maintenant, on s'intéresse à l'administration / gouvernance / pilotage

Le système de santé est « déconcentré »

Organisation **décentralisée**
=
le pilotage se fait sur plusieurs échelons ou strates territoriales



Organisation **déconcentrée**
=
le pilotage est centralisé puis se déploie sur le territoire



64

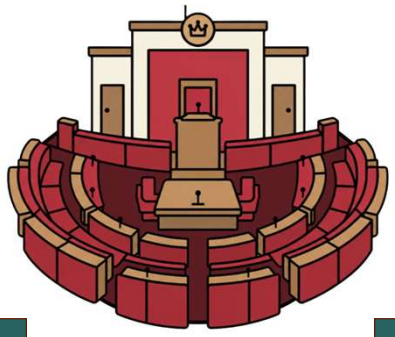
Le système a une **organisation déconcentrée**, qui n'est pas la même chose qu'une organisation décentralisée.

Organisation **décentralisée** = le pilotage se fait sur plusieurs échelons ou strates territoriales
Exemple : *Education nationale :* le ministère emploie les professeurs, Mais la gestion des lycées, collèges, et écoles revient respectivement aux régions, aux départements, et aux mairies …

Organisation **déconcentrée** = le pilotage est centralisé puis se déploie sur le territoire
Exemple : *système de santé :* piloté depuis le ministère (± la CNAM), et dont les choix politiques se déploient ensuite via les ARS, les CPAM, etc.

Le Parlement

Echelon national



Lois de santé « quinquennales »

Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) annuelle

Objectif National des Dépenses de l'Assurance maladie (ONDAM)

65

Le Parlement est constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Il vote :

- Les lois de santé « quinquennales » : qui organisent le système de santé
- Les lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) annuellement :
    - Tous les ans, pour fixer le budget de l'année suivante
    - Pour la branche santé, fixe l'Objectif National de Dépenses de l'Assurance Maladie (Ondam)

Les premières lois santé



Les premières lois santé : 1902

Loi de 1902

Maladies à déclaration obligatoire

Vaccinations obligatoires

Hygiène et surveillance des décès **(veille sanitaire)**

Lutte contre les fléaux : alcool, tuberculose



1902 — **1945** — **1958** — **2002**

Les premières lois santé : 1945

1902 — 1945 — 1958 — 2002

Ordonnances de 1945

Création de la Sécurité Sociale

4 branches, 3 caisses nationales

- Maladie + Accidents du travail et maladies professionnelles – CNAM (CN Assurance Maladie)
- Famille – CNAF (CN Allocations familiales)
- Vieillesse – CNAV (CN Assurance vieillesse)



68

Les premières lois santé : 1958

Réforme hospitalo-universitaire Debré
Création des CHU
l'hôpital s'unit à la faculté pour une triple mission :
Soin + Enseignement + Recherche



1902 — 1945 — 1958 — 2002

69

Les premières lois santé : 2002

1902 — 1945 — 1958 — 2002



Loi du 4 mars 2002
(Kouchner)
Renforcement des **droits du patient**

70

Loi de 1902

Maladies à déclaration obligatoire
Vaccinations obligatoires
Hygiène et surveillance des décès **(veille sanitaire)**
Lutte contre les fléaux : alcool, tuberculose

Réforme hospitalo-universitaire Debré

Création des CHU

1902 — **1945** — **1958** — **2002**

Ordonnances de 1945

Création de la Sécurité Sociale
4 branches, 3 caisses nationales

- Maladie + Accidents du travail et maladies professionnelles – CNAM (CN Assurance Maladie)
- Famille – CNAF (CN Allocations familiales)
- Vieillesse – CNAV (CN Assurance vieillesse)

Loi du 4 mars 2002

(Kouchner)
Renforcement des **droits du patient**

71

Dernières lois de santé : 2009

Loi Bachelot (HPST)

Création des Agences régionales de santé (ARS) et des ESPIC



2009 — 2016 — 2019 — 2023

72

ESPIC : Etablissement de santé privé à intérêt collectif

Dernières lois de santé : 2016



Loi Touraine (LMSS)

Loi de modernisation du système de santé

- Généralisation du tiers payant
- Création des CPTS, GHT et de Santé Publique France
- Généralisation du DMP
- Infirmière en pratique avancée
- Lutte contre le tabac

73

GHT : groupement hospitalier territorial

Dernières lois de santé : 2019

Loi Buzyn (Ma Santé 2022)

- Réforme des études médicales avec suppression du numerus clausus et ouverture des LAS et PASS
- Développement des assistants médicaux
- Généralisation du DMP et Mon Espace Santé



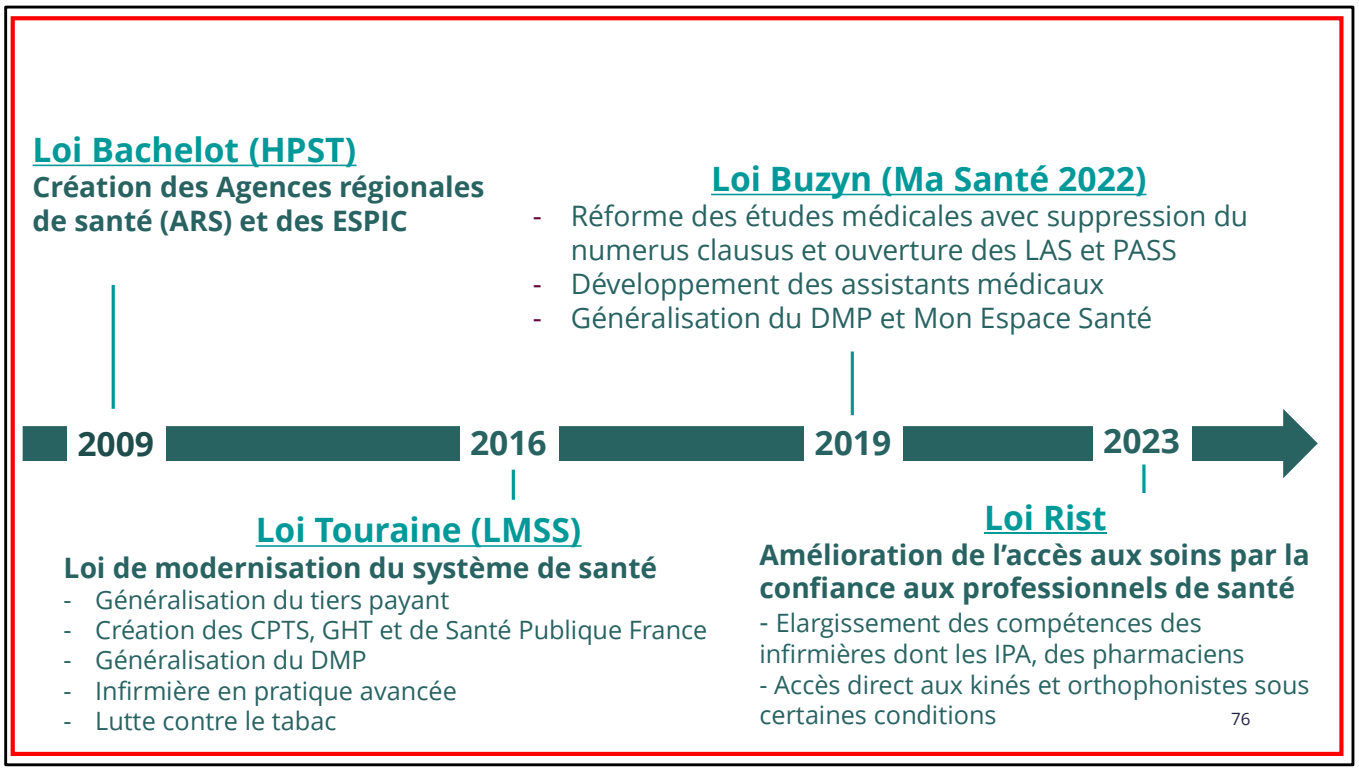
Dernières lois de santé : 2023



Loi Rist

Amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé

- Elargissement des compétences des infirmières dont les IPA, des pharmaciens
- Accès direct aux kinés et orthophonistes sous certaines conditions


Loi Bachelot (HPST)
Création des Agences régionales de santé (ARS) et des ESPIC
Loi Buzyn (Ma Santé 2022)
- Réforme des études médicales avec suppression du numerus clausus et ouverture des LAS et PASS
- Développement des assistants médicaux
- Généralisation du DMP et Mon Espace Santé
2009
2016
2019
2023
Loi Touraine (LMSS)
Loi de modernisation du système de santé
- Généralisation du tiers payant
- Création des CPTS, GHT et de Santé Publique France
- Généralisation du DMP
- Infirmière en pratique avancée
- Lutte contre le tabac
Loi Rist
Amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé
- Elargissement des compétences des infirmières dont les IPA, des pharmaciens
- Accès direct aux kinés et orthophonistes sous certaines conditions
76

Le ministère de la santé

Echelon national

MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ,
DES SOLIDARITÉS
ET DES FAMILLES

Liberté
Égalité
Fraternité

Ministère délégué

MINISTÈRE
DE LA SANTÉ
ET DE LA PRÉVENTION

Liberté
Égalité
Fraternité

77

Les lois qui sont votées au Parlement sont ensuite adaptées au niveau national par le Ministère de la Santé.

Le ministère de la santé

Echelon national

5 grandes directions

DGS	DGOS	DSS	DGCS	DREES
Direction générale de la Santé	Direction générale de l'Offre de Soins	Direction de la Sécurité Sociale	Direction générale de la cohésion sociale	Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques

MINISTÈRE
DE LA SANTÉ
ET DE LA PRÉVENTION
Liberté
Égalité
Fraternité

1 corps d'inspection

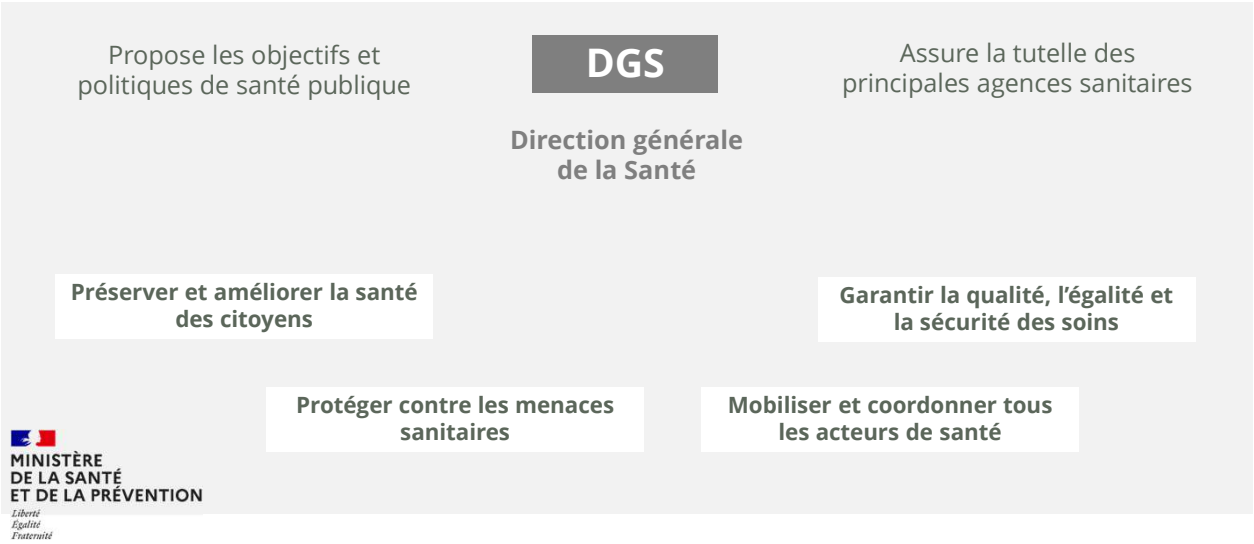
IGAS

Inspection Générale des Affaires Sociales

78

Le ministère de la santé : DGS

Echelon national



Missions :

- **propose les objectifs et politiques** de santé publique
- assure la **tutelle** des **principales agences sanitaires**

4 grands objectifs :

- Préserver et améliorer la santé des citoyens
- Protéger contre les menaces sanitaires
- Mobiliser et coordonner tous les acteurs
- Garantir la qualité, l'égalité et la sécurité des soins

Le ministère de la santé : DGOS

Echelon national

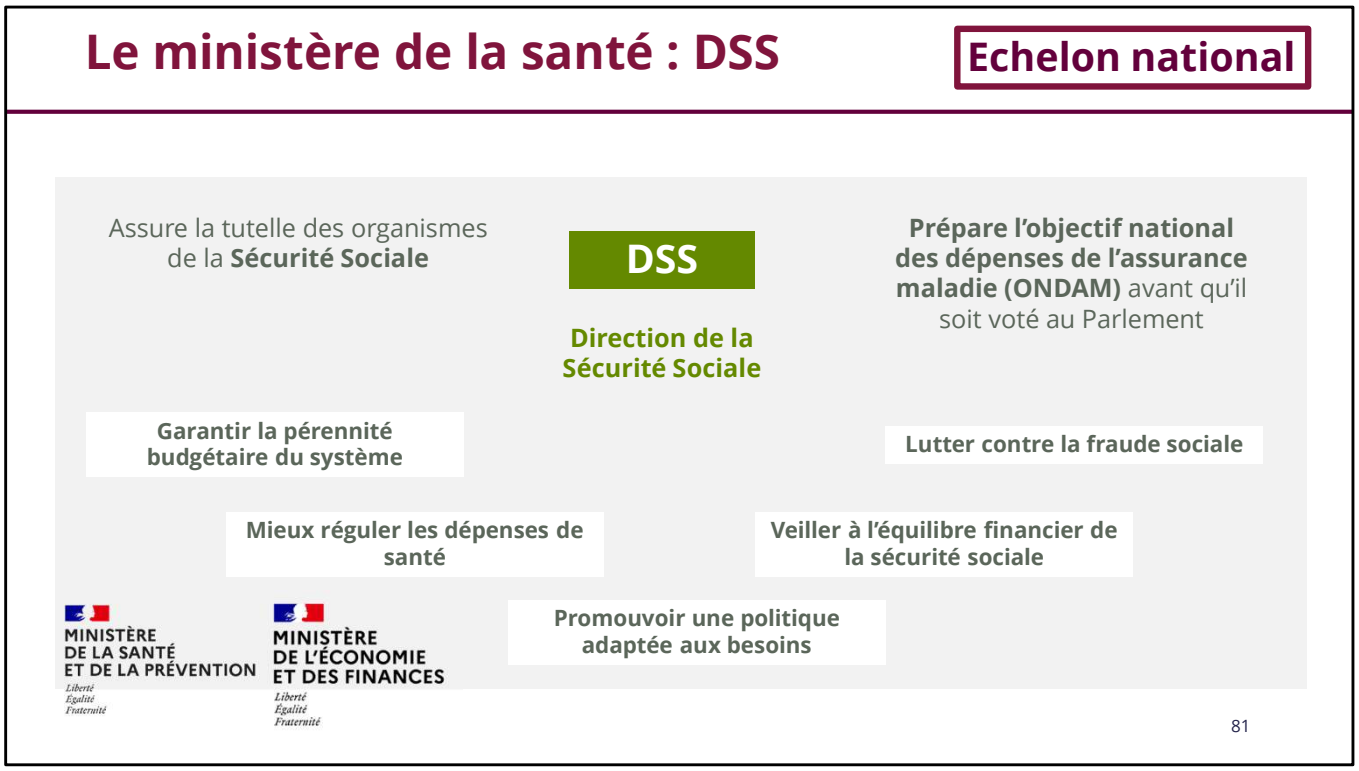


Mission :

- **pilotage stratégique** de l'offre de soins

4 grands objectifs :

- Adéquation de l'offre avec les besoins des territoires
- Réponse sanitaire adaptée aux besoins
- Renforcer performance + qualité + sécurité des soins
- Respect du droit et de la place des usagers



Double tutelle : ministère de la Santé et ministère des finances

Mission :

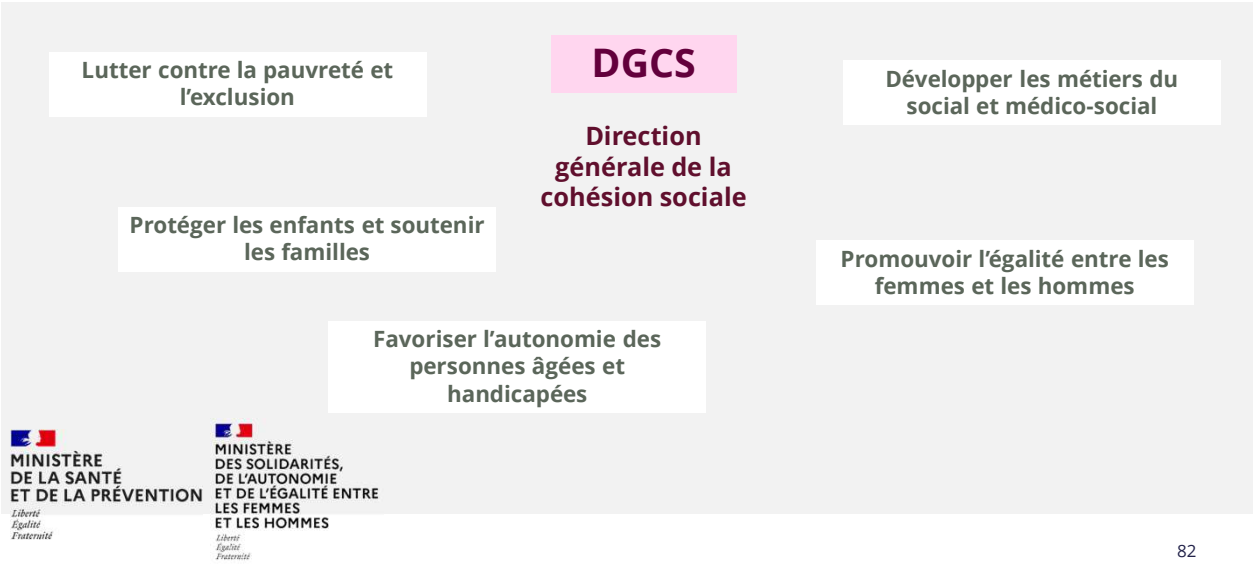
- **assure la tutelle** des organismes de la Sécurité Sociale,
- prépare **l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie (ONDAM)** avant qu'il soit voté au parlement

5 grands objectifs :

- Garantir la pérennité budgétaire du système
- Mieux réguler les dépenses de santé
- Promouvoir une politique adaptée aux besoins
- Veiller à l'équilibre financier de la sécurité sociale
- Lutter contre la fraude sociale

Le ministère de la santé : DGCS

Echelon national



82

Objectifs :

- Lutter contre la pauvreté et l'exclusion
- Protéger les enfants et soutenir les familles
- Favoriser l'autonomie des personnes âgées et handicapées
- Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes
- Développer les métiers du social et médico-social

Le ministère de la santé : DGS

Echelon national

fournir aux décideurs publics, aux responsables économiques et aux citoyens des informations fiables sur les sujets sanitaires et sociaux

DREES

Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques

Réalise des analyses et communique les résultats

MINISTÈRE
DE LA SANTÉ
ET DE LA PRÉVENTION
Liberté
Égalité
Fraternité

83

Mission : fournir aux décideurs publics, aux responsables économiques et aux citoyens des **informations fiables sur les sujets sanitaires et sociaux**

Réalise les analyses et communique les résultats

Les agences régionales de santé (ARS) — Echelon régional



Les Agences Régionales de Santé (ARS) sont les acteurs locaux (au niveau régional).
Elles ont pour but d'appliquer la politique de santé du Ministère de la Santé au niveau régional.

https://www.youtube.com/watch?v=nB0WIsoj5Uc

Acteurs internationaux

Echelon international

Echelon mondial

Organisation mondiale de la Santé

unicef

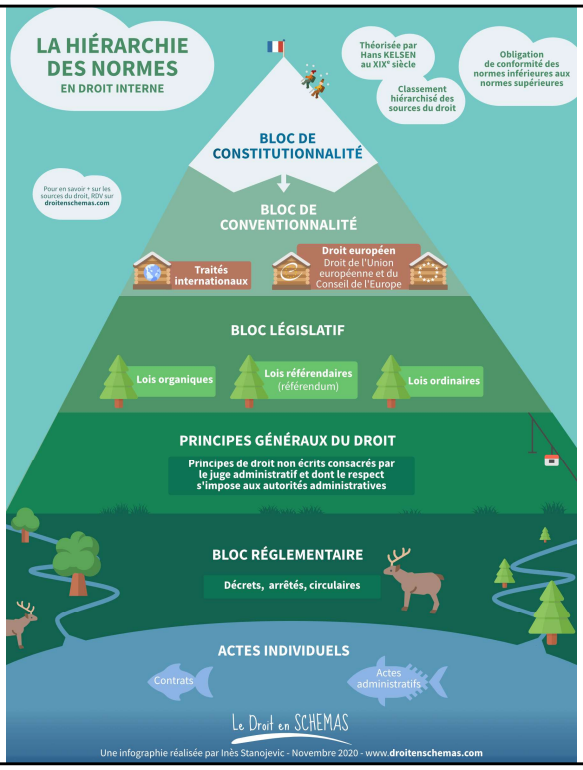
Echelon européen

Parlement européen

Commission européenne
DG Santé

85

Il y a également des acteurs internationaux qui peuvent influencer les politiques de santé en France.



86

(Pas à connaître par cœur)

Dans la hiérarchie des normes, juste en dessous de la Constitution Française, on a les traités internationaux et le droit Européen, qui sont légalement au dessus des lois françaises.

Dans les diapos suivantes, on va voir deux exemples de lois européennes qui ont été adaptées en France

Exemple de transposition dans le droit commun



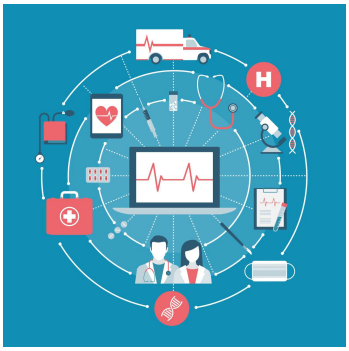
Directive européenne 2014/40/UE du 3 avril 2014
→ Règles concernant la fabrication et vente des produits du tabac : mise en place d'**avertissements sanitaires de grande taille sur les paquets**

→

Ordonnance du 19 mai 2016
→ Mise en place d'**avertissements sanitaires illustrés sur les paquets**

87

Exemple de transposition dans le droit commun



Règlement général sur la protection des données (RGPD) UE2016/679 adopté le 27 avril 2016
→ Règles concernant la protection des données personnelles dont les données de santé

→

Application à partir du 25 mai 2018

88

Les agences sanitaires

Echelon national



Les agences sanitaires sont des organismes sous la tutelle de Ministère de la Santé, qui sont capables de **donner des avis scientifiques** aux décideurs politiques.

Exemples : Santé Publique France, ANSM, ANSES, EFS, Agence de la biomédecine, INCa, etc.

Missions relatives à :

- La sécurité sanitaire (produits de santé, aliments, travail, radiations ionisantes, environnement)
- La veille sanitaire
- La prévention
- La transfusion sanguine et la greffe d'organes

Haute autorité de santé (HAS) — Echelon national

Organisme d'expertise scientifique **indépendant**

HAS
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Evaluation des produits de santé et des actes de santé

Evaluation et amélioration de la qualité des soins

Certification des établissements de santé

Elaboration des recommandations de bonne pratique

90

La Haute Autorité de Santé (HAS) est un organisme d'expertise scientifique, consultatif et **indépendant**

Compétences :

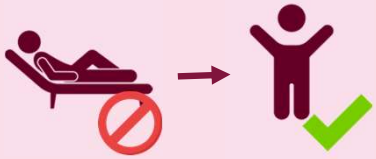
- **Evaluation médico-économique** des actes, prestations, et produits de santé pris en charge par l'Assurance maladie
- **Certification** des établissements de santé (sécurité et qualité)
- Définition et promotion des **bonnes pratiques** et **bon usage des soins** auprès des professionnels de santé et du grand public
- Amélioration de la **qualité et de la sécurité des soins** (mise à disposition des professionnels d'outils, guides et méthodes)

Evaluation du soin





Qualité



Pertinence



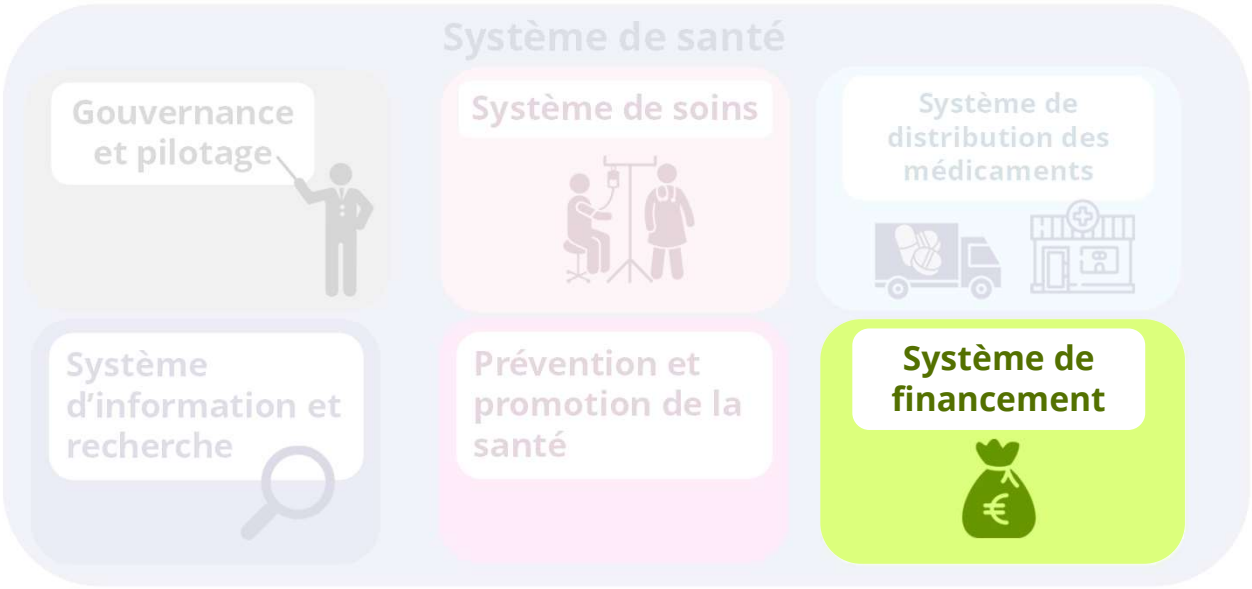
Efficience

91

On peut évaluer un soin de plusieurs manières :

- Est-ce que ce soin est réalisé correctement ? = **Qualité** du soin
- Est-ce que ce soin est utile au patient ? = **Pertinence** du soin
- Est-ce que ce soin est bénéfique au patient comparativement à son coût (rapport entre le coût du soin et son bénéfice) ? = **Efficience** du soin

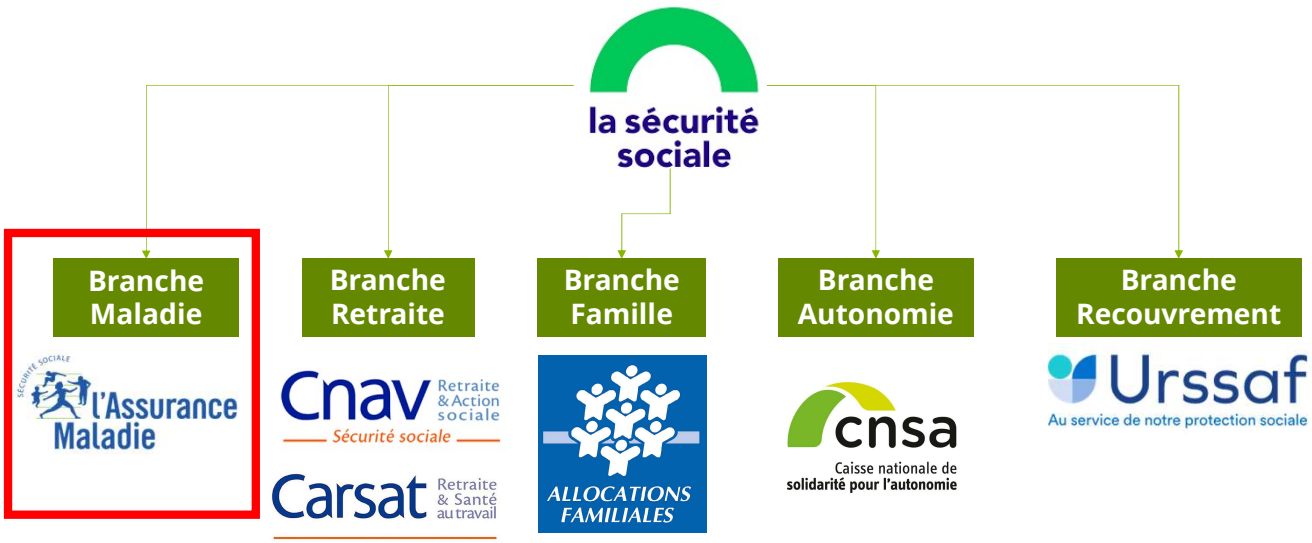
PARTIE 3 – Le système de financement



92

On va voir quelques acteurs du système de financement.
Cette partie sera développée dans le cours sur l'économie de la santé.

Sécurité sociale



93

La sécurité sociale est un système public français de protection (qui protège la population contre certains risques de la vie :

- La maladie, les accidents de travail et maladies professionnelles (branche maladie)
- La vieillesse (branche retraite)
- La maternité, famille et les enfants (branche famille)
- La perte d'autonomie (branche autonomie)

Assurance maladie : CNAM

Echelon national

Double tutelle

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

SÉCURITÉ SOCIALE L'Assurance Maladie

Caisse nationale

Maitrise médicalisée des dépenses dans le cadre contraint de l'Objectif national de dépenses d'Assurance maladie (ONDAM)

Fixe les grandes orientations de l'Assurance maladie

Négociation des accords nationaux avec les représentants des professionnels de santé (tarifs des actes)

Pilote les budgets et les objectifs, coordonne et suit l'activité des CPAM

Organisation des actions nationales de prévention

94

L'Assurance maladie assure la gestion des **branches maladies** (risque maladie, maternité, invalidité, décès) et **accidents du travail/maladies professionnelles (AT-MP)** du régime général de la sécurité sociale

Au niveau national, la caisse nationale de l'assurance maladie a pour objectif la **maitrise médicalisée des dépenses** = toutes les actions destinées à maîtriser les dépenses par des gains d'efficience en restant dans une logique médicale.

Elle est sous la double tutelle du ministère de la santé et du ministère de l'Économie et des finances

Elle doit agir dans un cadre contraint : Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam)

Assurance maladie : CPAM

Echelon local

Double tutelle

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

SÉCURITÉ SOCIALE L'Assurance Maladie

Caisse primaire

Accompagnement et gestion des droits des assurés via la Carte Vitale

Versement des indemnités journalières (arrêt de travail)

Remboursement des consultations, médicaments et soins pris en charge

Actions locales de prévention et lutte contre le non-recours aux droits

95

Au niveau départemental, les Caisses primaires de l'Assurance maladie mettent en œuvre localement les actions.

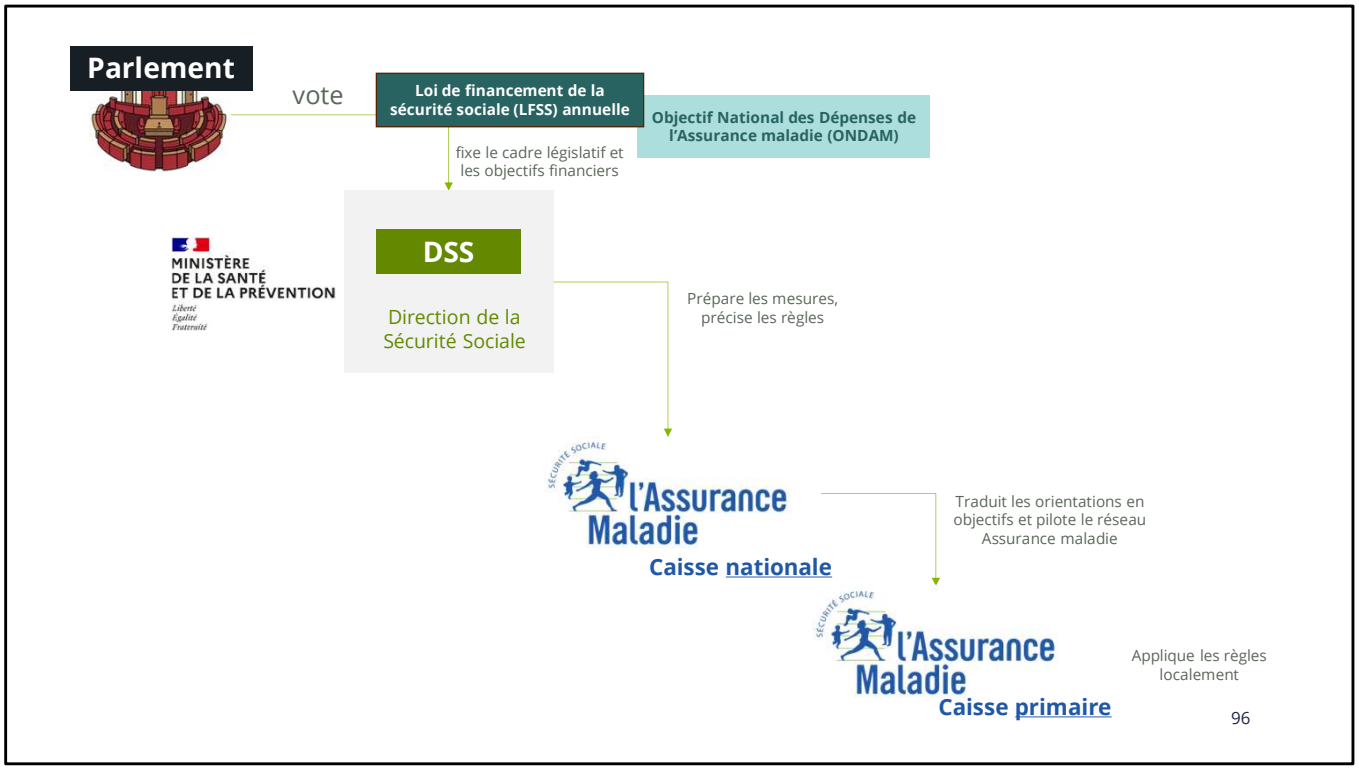


Schéma récapitulatif

Autres acteurs dans le financement du système de santé : la complémentaire santé



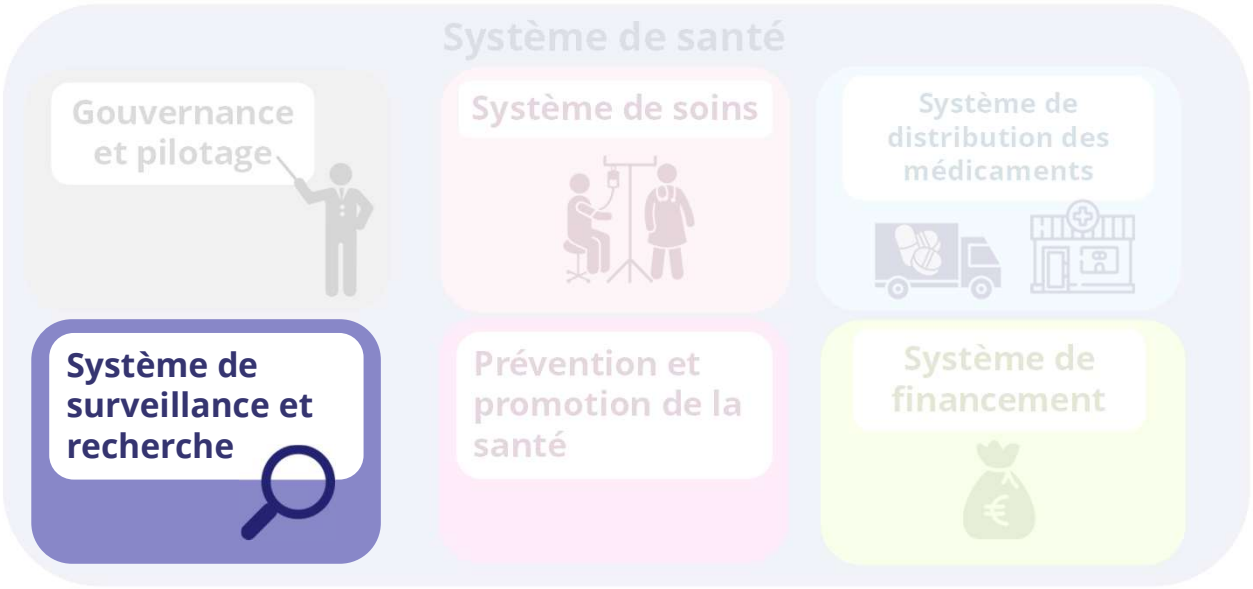
97

(Noms donnés à titre indicatif, ne pas retenir tous ces noms d'assurance)

La **complémentaire santé** permet de prendre en charge une partie ou la totalité du reste à charge, c'est-à-dire la partie du frais de soin non remboursée par l'Assurance maladie.

Ne pas confondre complémentaire santé et mutuelle !
Une **mutuelle** est un organisme à but non lucratif qui propose des complémentaires santé.
Toutes les complémentaires santé ne sont pas forcément proposées par des mutuelles. Il peut y avoir aussi des organismes à but lucratif comme des sociétés d'assurance ou de prévoyance qui en proposent.

PARTIE 4 – Le système de la surveillance sanitaire et recherche en santé



98

Quelques mots sur la surveillance sanitaire et la recherche en santé

Surveillance sanitaire



99

La surveillance sanitaire consiste à recueillir et analyser les informations sur l'état de santé de la population afin de **détecter les risques sanitaires** et **suivre l'évolution des maladies**. Exemples : VIH, COVID-19

L'ECDC (en anglais : European Centre for Disease Prevention and Control, en français : Centre européen de prévention et de contrôle des maladies en français) est une agence de l'Union européenne qui surveille **la propagation des épidémies en Europe** et qui réalise des recommandations en matière de prévention.

Santé publique France est l'agence nationale de Santé publique en France.
Elle a pour missions :

- **Veille sanitaire** : observation épidémiologique et **surveillance** de l'état de santé des populations, veille sur les risques sanitaires menaçant les populations
- **Promotion de la santé**
- **Gestion de crise :** lancement de l'alerte sanitaire, préparation et réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires

Agence Nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est une agence nationale qui a pour missions : Sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation + Santé et bien être animal + Santé végétale + Propriétés nutritionnelles des aliments + Médicaments vétérinaires (approche One Health)

Localement, la surveillance sanitaire est réalisée par les **Agences Régionales de Santé**.

Surveillance de la sécurité des produits de santé



100

On surveille également la **sécurité des produits de santé** :

- **Médicaments** = pharmacovigilance, et **dispositifs médicaux** = matériovigilance, par l'ANSM (France) et l'EMA (Europe)
- **Produits sanguins labiles** = hématovigilance, par l'ANSM et l'EFS
- **Transplantation d'organes** = biovigilance, par l'Agence de la biomédecine

L'EMA (agence européenne du médicament) garantit que les médicaments commercialisés dans l'Union européenne sont sûrs, efficaces et de haute qualité.
Elle assure l'évaluation scientifique, la surveillance et le contrôle de la sécurité des médicaments au sein de l'Union Européenne.

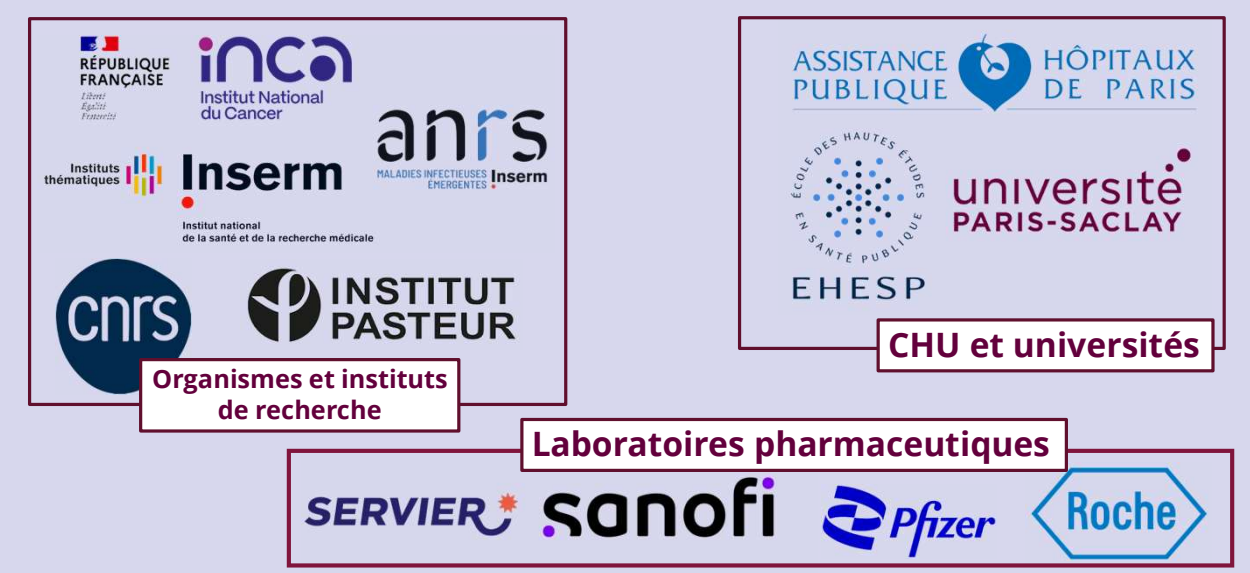
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
est une agence placée sous la tutelle du ministère chargé de la Santé.
Elle assure, au nom de l'Etat, la sécurité des produits de santé et favorise l'accès à l'innovation thérapeutique. Elle évalue les bénéfices et risques liés à l'utilisation des produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux) mais aussi produits biologiques d'origine humaine, cosmétiques, tatouages ...

Agence de la biomédecine : Autorité de référence sur les aspects médicaux, scientifiques, et éthiques liés aux greffes (Greffes d'organes, de tissus et de cellules + Procréation, embryologie et génétique humaine)

Etablissement français du sang (EFS)

- Collecte, préparation, qualification et distribution des **produits sanguins labiles**
- Mission de service public ; assurer l'autosuffisance de la France dans des conditions de sécurité et qualité optimale

Recherche en santé



101

(Noms donnés à titre indicatif, ne pas retenir tous ces noms mais retenir leurs « groupes »)

Il y a plusieurs acteurs dans la recherche et l'innovation en santé :

- CHU et les universités
- Organismes et instituts de recherche
- Laboratoires pharmaceutiques

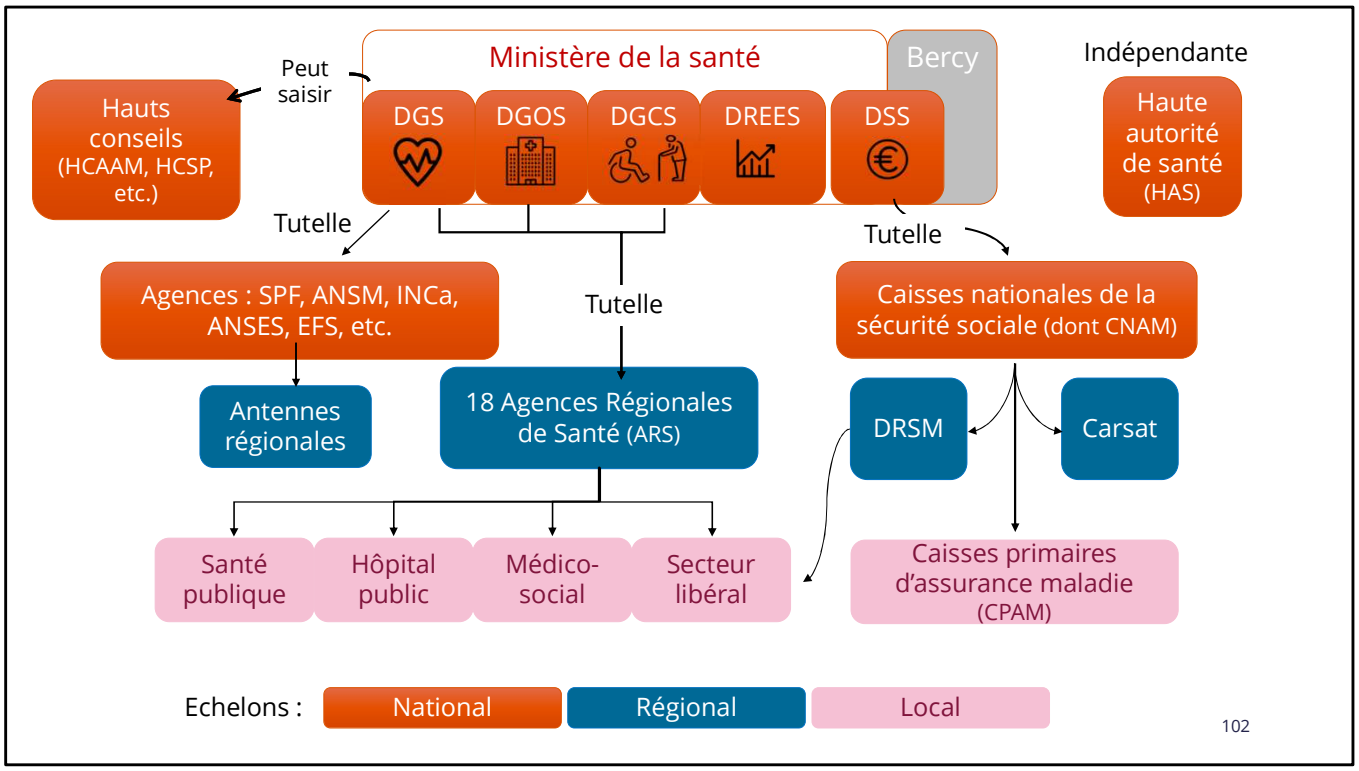


Schéma récapitulatif

université
PARIS-SACLAY

Merci pour votre attention

Lexique

- **Ministère de la Santé et de la Prévention** (≈ pouvoir exécutif central)
  - **DGS** : Direction Générale de la Santé
  - **DGOS** : Direction Générale de l'Offre de Soins
  - **DSS** : Direction de la Sécurité Sociale
  - **DGCS** : Direction Générale de la Cohésion Sociale
  - **DREES** : Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques

- **ARS** : Agence Régionale de Santé (≈ antenne régionale du Ministère)

- **SS** : Sécurité sociale (comprend 4 branches : retraites, maladies, familles, et AT/MP)
- **CNAM** : Caisse Nationale d'Assurance Maladie (gère la branche maladies de la SS)
- **AT/MP** : Accident du Travail / Maladies Professionnelles

- **SPF** : Santé Publique France
- **HAS** : Haute Autorité de Santé
- **INCa** : Institut National du Cancer

Lexique

- **HPST** : Loi « Hôpital Patient Santé Territoire » (voté sous Bachelot en 2009)
- **LFSS** : Loi de Financement de la Sécurité Sociale
- **ONDAM** : Objectif National de Dépenses de l'Assurance Maladie
- **T2A** : Tarification À l'Activité (≈ mode de financement actuel de l'hôpital (≈ à l'acte))

- **ES/EMS** : Etablissement de Santé / Etablissement Médico-Social
- **PS** : Professionnel de Santé (≈ professions médicales + paramédicaux + pharmacien)
- **MSP** : Maison de Santé Pluridisciplinaire (≈ PS libéraux qui travaillent ensemble)
- **CDS** : Centre de santé (≈ PS salariés mais exerçant une activité en ville)
- **CPTS** : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (≈ MSP hors les murs)
- **IDE** : Infirmier Diplômé d'Etat
- **IPA** : Infirmier en Pratiques Avancées (≈ infirmier spécialisé niveau Master)

- **DMP** : Dossier Médical Partagé (≈ dossier en ligne accessible au patient et aux PS)
- **DPC** : Développement Professionnel Continu (≈ formation continue)